

Faculté de Médecine Oran
Annexe Tiaret



@CUREOLOGY
Contactez-nous



ANAPATH IMMUNO

3^{ème} Année Médecine

QCM Classés par cours



2025- 2026





Welcome to CUREOLOGY

Méthode de CURE :

I - Analysez chaque question attentivement afin de distinguer la bonne réponse des mauvaises.

I - Pathologie Cellulaire & Tissulaire

Pathologie Cellulaire & Tissulaire

1. Introduction à l'ACP

1. Concernant les prélèvements cytologiques

- A- Ils permettent de faire un diagnostic de certitude.
- B- Ils constituent l'examen de choix pour le dépistage du cancer du col utérin.
- C- Le prélèvement peut être fixé à l'air.
- D- Le fixateur de choix est le formol.
- E- Peut se faire en utilisant une aiguille.

Source: Q51 P2022 & Q65 P2021

II - À la fin de chaque cours, vous trouverez les Qst à compléter dans des cases vides, comme une simulation d'examen, pour votre première tentative.

	A	B	C	D	E
Q1	☒	☒	☐	☒	☐
Q2	☒	☒	☐	☒	☒

	A	B	C	D	E
Q3	☒	☒	☒	☐	☐
Q4	☒	☐	☒	☐	☒

III - À la fin de chaque chapitre, vous aurez accès aux corrigés types officiels, vous permettant de vérifier et consolider vos réponses.

RÉPONSES

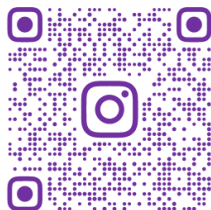
1. Introduction à l'ACP

	A	B	C	D	E
Q1	☒	☒	☒	☐	☐
Q2	☒	☒	☐	☒	☒

	A	B	C	D	E
Q3	☒	☒	☒	☐	☐
Q4	☒	☐	☒	☐	☐

@cureology

@cureology_



CUREOLOGY_



@CUREOLOGY

Nos Caractéristiques :

Classement par cours :

- Les questions sont regroupées par cours, conformément au programme officiel, pour un apprentissage clair et progressif.

Organisation logique :

- Les leçons suivent un ordre cohérent, facilitant la compréhension et la révision méthodique.

Source complète :

- Chaque question indique sa source exacte, avec le numéro correspondant dans le document original, garantissant la fiabilité du contenu.

Navigation interactive :

- Un simple clic sur le numéro de page dans l'index vous conduit directement à la leçon concernée, rendant la consultation rapide et fluide.

Lien de retour :

- En bas de chaque page, un lien vous ramène à l'index, éliminant tout besoin de scroll manuel et les allers-retours inutiles.

Simulation d'examen :

- La présentation reprend la structure d'un examen officiel : des cases vides pour vos réponses et les solutions à la fin du chapitre.

Apprentissage actif :

- Les réponses sont séparées des questions afin de stimuler la réflexion et la mémorisation.

Design unique :

- Un style visuel moderne, clair et exclusif, conçu pour une expérience de lecture efficace.

Accès Gratuit illimité, valeur maximale :

- Tout le contenu est mis à votre disposition **Gratuitement 100%** – sans aucune restriction

Usage personnel uniquement :

- Réutilisation commerciale du contenu sans autorisation est interdite

SOMMAIRE

I -Immunologie	1
1. Immunopathologie	1
2. Immunité Antibactérienne	1
3. Immunité Antiparasitaire.....	1
4. Immunité Antivirale	2
5. Hypersensibilité type I	3
6. Hypersensibilité type II	6
7. Hypersensibilité type III	8
8. Hypersensibilité type IV	9
9. Autoimmunité	10
10. Déficits Immunitaires	12
11. Syndromes Lymphoprolifératifs	16
12. Transplantation (Greffe)	19
13. Immunothérapie & Immunosuppression.....	20
14. Techniques d'Immunoprécipitation	23
15. Réaction d'Agglutination et d'Hémoagglutination	23
16. Techniques Immunologiques utilisant des anticorps marqués	24
17. Autres.....	24
RÉPONSES – QCM	25
RÉPONSES – QROC	25

IMMUNOLOGIE

1. Immunopathologie

1. Est considérée comme étant une immunopathie, tout(e) :

- A- maladie métabolique.
- B- type d'asthme.
- C- vascularite.
- D- granulomatose.
- E- infection intra cellulaire.

Source: Q1 P2020

2. les états d'hypersensibilité :

- A- Se manifestent cliniquement dès le premier contact avec l'allergène.
- B- Se caractérisent par une réaction inflammatoire.
- C- Sont toujours dus à des réponses immunitaires humorales.
- D- Sont classés en 4 types selon la nature de l'allergène.
- E- Peuvent donner des manifestations cliniques systémique ou locales.

Source: Q1 P2018

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q2	☐	☐	☐	☐	☐

2. Immunité Antibactérienne

1. Quels récepteurs reconnaissent les motifs moléculaires associés aux pathogènes (PAMPs) bactériens ?

- A- TCR.
- B- BCR.
- C- Les récepteurs des chimiokines,.
- D- Les molécules d'adhésion cellulaire,.
- E- Les PRRs.

Source: Q1 P2022

2. Les éléments/mécanismes suivants font partie des mécanismes innés de la défense antibactérienne :

- A- La sécrétion des larmes.
- B- Les acides gras libres de la surface cutanée.
- C- Le microbiote intestinal.
- D- La neutralisation des bactéries par les IgM.
- E- Les Beta-défensines.

Source: Q2 P2020

3. Les PRR (récepteurs de l'immunité innée) :

- A- Reconnaittent spécifiquement une bactérie.
- B- Sont exprimés exclusivement par les cellules phagocytaire.
- C- Activent une signalisation pro-inflammatoire dans la cellule.
- D- Existent sous forme sécrétée.
- E- Sont constitués de plusieurs familles.

Source: Q3 P2020

4. A propos des mécanismes de défense contre les bactérie intra cellulaire :

- A- La réponse contre les bacille de Koch implique la production de l'INF- γ .
- B- L'immunité humorale est très efficace.
- C- Le LT CD4+ joue un rôle primordial.
- D- La phagocytose est efficace contre toutes les bactéries intra cellulaires.
- E- Le LT CD8+ peut participer à la réponse contre les bactéries.

Source: Q1 P2019

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q3	☐	☐	☐	☐	☐
Q4	☐	☐	☐	☐	☐

3. Immunité Antiparasitaire

1. A propos de la réponse immunitaire antiparasitaire :

- A- Les mécanismes de défense sont identiques pour tous les parasites.
- B- Les métazoaires activent des mécanismes de défense cellulaires et humoraux.
- C- Les polynucléaires éosinophiles contribuent essentiellement par la phagocytose des parasites.
- D- Les polynucléaires neutrophiles n'ont aucun rôle dans la défense antiparasitaire.
- E- Les NK produisent de l'IFN- γ en réponse aux infections parasitaires.

Source: Q3 P2021

2. Les mécanismes suivants sont utilisés par les parasites pour échapper à la réponse immunitaire :

- A- Production de facteurs suppresseurs par le parasite.
- B- Acquisition d'antigènes de l'hôte.
- C- Augmentation de l'expression des molécules de costimulation (B7.1, B7.2).
- D- Augmentation de la présentation des antigènes parasitaires sur les molécules HLA.
- E- Polymorphisme des gènes codant pour les protéines parasitaires.

Source: Q4 P2021 RATRAPAGE

3. la réponse immunitaire contre les protozoaires :

- A- Est une réponse à prédominance Th2.
- B- La réponse humorale n'a aucun rôle.
- C- Peut générer la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires par activation des macrophages.
- D- Peut impliquer les LT cytotoxiques.
- E- Peut générer les LT mémoires.

Source: Q4 P2020

4. L'échappement des parasites au système immunitaire implique les mécanismes suivants :

- A- La séquestration anatomique et l'enkystement.
- B- L'induction de la LT régulateurs.
- C- L'augmentation de l'expression des molécules HLA.
- D- La modification des antigènes du parasite.
- E- L'activation de la voie alterne du complément.

Source: Q5 P2020

5. Parmi les mécanismes d'échappement des parasite à la réponse immunitaire :

- A- La séquestration anatomique.
- B- L'induction d'une réponse Th1.
- C- L'augmentation de l'expression des molécules HLA II sur les cellules présentatrices d'antigène.
- D- la variation antigénique.
- E- L'inhibition des lymphocyte T régulateurs.

Source: Q2 P2019

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐
Q3	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q4	☐	☐	☐	☐	☐
Q5	☐	☐	☐	☐	☐

4. Immunité Antivirale

1. Les lymphocytes T cytotoxiques anti-virus :

- A- jouent un rôle important dans la guérison des infections virales.
- B- sont restreints le plus souvent par les antigènes d'histocompatibilité de classe II.
- C- n'agissent qu'en présence d'un anticorps de classe IgG.
- D- n'agissent qu'en présence d'un anticorps de classe IgM.
- E- sont un support important de l'immunité innée.

Source: Q2 P2022

2. Parmi les effecteurs suivants, lequel est le plus efficace dans la défense antivirale ?

- A- Le complément,.
- B- Les polynucléaires éosinophiles,.
- C- Les cellules épithéliales,.
- D- Les cellules T cytotoxiques CD8+,.
- E- Les polynucléaires neutrophiles.

Source: Q3 P2022

3. Les effecteurs impliqués dans la réponse immunitaire antivirale sont :

- A- lymphocytes NK.
- B- Les Les immunoglobulines IgG.
- C- Les lymphocytes TH2.
- D- Les macrophages.
- E- Les polynucléaires éosinophiles.

Source: Q1 P2021

4. La latence virale :

- A- Décrit un état de dormance d'un virus dans l'organisme.
- B- Se produit lorsque le système immunitaire n'arrive pas à éliminer un virus complètement.
- C- Se produit en cas de déficit immunitaire de l'organisme hôte.
- D- Se produit lorsqu'il y a réarrangement des gènes du virus chez une espèce animale.
- E- Est un phénomène caractérisant les virus de la famille des Herpesviridae.

Source: Q2 P2021

5. L'effecteur humoral impliqué dans la réponse immunitaire antivirale est :

- A- L'immunoglobuline IgG.
- B- Le lymphocyte TH2.
- C- Le mastocyte des muqueuses.
- D- Le lymphocyte NK.
- E- Le polynucléaire basophile.

Source: Q5 P2021 RATRAPAGE

6. Les interférons de types I sont :

- A- Les interférons α et β .
- B- Les interférons γ et δ .
- C- Sécrétés par toutes les cellules infectées par un virus.
- D- Sécrétés seulement par des cellules immunitaires lymphoïdes.
- E- Impliqué dans l'immunité adaptative cellulaire.

Source: Q6 P2021 RATRAPAGE & Q22 P2018

7. Les réponses immunes antivirales impliquent :

- A- Les cellules NK.
- B- Les cellules dendritiques plasmacytoïdes.
- C- Les lymphocytes TCD8+.
- D- Les polynucléaires éosinophiles.
- E- Les polynucléaires basophiles.

Source: Q7 P2021 RATRAPAG & Q21 P2018

8. Les récepteurs de l'immunité innée responsable de la détection des acides nucléiques viraux sont :

- A- TLR2.
- B- TLR3.
- C- TLR4.
- D- TLR7.
- E- TLR9.

Source: Q6 P2020

9. Les anticorps dans la réponse immunitaire antivirale :

- A- Préviennent la primo-infection.
- B- Inhibent la réplication du génome viral.
- C- Inhibent l'assemblage de la capsid virale.
- D- Participent à la lyse de l'enveloppe virale.
- E- Neutralisent les virions libérés après lyse cellulaire.

Source: Q7 P2020

10. Citer 04 mécanismes d'échappement immunitaire des virus :

Source: Q1 P2020 RATRAPAGE

(QROC).

11. Les interféron α :

- A- Sont produits par toute cellules infectée par un virus.
- B- Agissent de manière autocrine et paracrine .
- C- Inhibent la synthèse des protéines virales dans la cellules cible.
- D- Inhibent l'activité cytotoxique des lymphocyte NK.
- E- Aboutissent à la stimulation des récepteurs de l'immunité Innée TLR3 et TLR7 4.

Source: Q3 P2019

12. les cellules immunitaires cytotoxiques :

- A- Peuvent être des cellules nk.
- B- Peuvent être des CTL.
- C- Sécrètent des molécules de perforine et de granzyme.
- D- Présentent le peptide immunodominant aux lymphocytes T.
- E- Ne peuvent pas provoquer l'apoptose par le FAS -FAS L.

Source: Q23 P2018

13. la présentation de l'antigène aux lymphocytes T par des cellules dendritiques peut suivre :

- A- La voie endogène si le peptide est synthétisé par la cellule dendritique.
- B- La voie exogène si le peptide est endocyté du milieu extracellulaire.
- C- La voie de crosse priming pour la présentation des antigènes viraux sur les molécules HLA II.
- D- La voie de crosse priming pour la présentation des antigènes viraux sur les molécules HLA I.
- E- La voie exogène si le peptide est présenté sur les molécules HLA I.

Source: Q24 P2018

14. la polarisation TH1 dans l'immunité antivirale :

- A- Nécessite la sécrétion de l'IL12 par la cellule dendritique.
- B- Est caractérisée par la sécrétion des cytokines IL2 et IFN γ .
- C- Facilite la cytotoxicité NK par l'induction de la synthèse des IgG.
- D- Induit la maturation des éosinophiles.
- E- Est nécessaire pour bloquer la réponse immunitaire.

Source: Q25 P2018

15. La réponse immune antivirale: (La RF)

- A- Elle fait intervenir essentiellement l'immunité humorale spécifique.
- B- Les interférons α et β bloquent la réplication virale et protègent les cellules non infectées.
- C- Les lymphocytes T cytotoxiques CTL sont très efficaces contre l'infection virale.
- D- Les cellules NK participent dans l'élimination des cellules infectées par le virus qui n'expriment pas le système HLA.
- E- L'immunité humorale par les anticorps neutralisants intervient surtout lors d'un deuxième contact avec même virus.

Source: Q18 EMD1 P2010

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐
Q3	☐	☐	☐	☐	☐
Q4	☐	☐	☐	☐	☐
Q5	☐	☐	☐	☐	☐
Q6	☐	☐	☐	☐	☐
Q7	☐	☐	☐	☐	☐
Q8	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q9	☐	☐	☐	☐	☐
Q10	☐	☐	☐	☐	☐
Q11	☐	☐	☐	☐	☐
Q12	☐	☐	☐	☐	☐
Q13	☐	☐	☐	☐	☐
Q14	☐	☐	☐	☐	☐
Q15	☐	☐	☐	☐	☐

5. Hypersensibilité type I

1. Les événements ayant lieu au cours de la phase de sensibilisation de l'hypersensibilité de type I sont :

- A- La production des IgE.
- B- La dégranulation du mastocyte.
- C- L'activation des cellules dendritiques.
- D- La commutation de classe des LB.
- E- La libération des médiateurs vasoactifs.

Source: Q4 P2022

2. Parmi les effets de l'histamine, on retrouve :

- A- Augmentation de la perméabilité capillaire.
- B- Recrutement des PNN et PNE.
- C- Agrégation des plaquettes.
- D- Broncho-constriction.
- E- Hypersécrétion du mucus.

Source: Q5 P2022

3. Lequel des produits mastocytaires suivants, n'est pas préformé :

- A- L'histamine.
- B- La prostaglandine D2.
- C- L'héparine.
- D- La Protéase neutre.
- E- Le facteur chimiotactique des éosinophiles (ECF).

Source: Q6 P2021

4. Les molécules suivantes sont produites par les mastocytes dans une réaction d'hypersensibilité de type I sauf un, lequel :

- A- L'histamine.
- B- La sérotonine.
- C- Les prostaglandines.
- D- L'IL-2.
- E- Le thromboxane.

Source: Q3 P2021 RATRAPAGE

5. Dans la phase effectrice précoce de l'hypersensibilité de type I, on retrouve les acteurs suivants :

- A- Les mastocytes.
- B- Les polynucléaires éosinophiles.
- C- Les prostaglandines.
- D- Les chimiokines.
- E- La sérotonine.

Source: Q8 P2020

6. Parmi les tests spécifiques d'exploration de l'hypersensibilité de type 1 :

- A- La formule sanguine.
- B- Le dosage des IgE totales.
- C- La recherche des IgE spécifiques de l'allergène.
- D- Le test d'activation des basophiles.
- E- Le dosage de l'histamine sanguine.

Source: Q9 P2020

7. Parmi les acteurs de la phase tardive de l'hypersensibilité de type 1 :

- A- L'histamine.
- B- L'IL-4.
- C- Les polynucléaires éosinophiles.
- D- polynucléaires basophiles.
- E- La sérotonine.

Source: Q4 P2019

8. Parmi les exemples pathologiques d'hypersensibilités de type 1 :

- A- La dermatite herpétiforme.
- B- La maladie de Goodpasture.
- C- La rhénite allergique.
- D- L'asthme atopique .
- E- L'urticaire allergique.

Source: Q5 P2019

9. parmi les acteurs de l'hypersensibilité de type I

- A- Les lymphocytes T régulateurs.
- B- Le lymphocyte B.
- C- L'interleukine 10.
- D- Le TGF- β .
- E- Le lymphocyte Th1.

Source: Q2 P2018

10. l'hypersensibilité de type 1

- A- Fait intervenir les IgE spécifique d'allergène.
- B- Se manifeste cliniquement après un bref délai suivant le 2em contact avec l'allergène.
- C- Est explorée spécifiquement par le dosage des IgE totales.
- D- Est explorée par le test cutané (prick test).
- E- Est traitée par le test de provocation.

Source: Q3 P2018

11. les médiateurs suivant sont impliqués dans la phase de sensibilisation de l'hypersensibilité type I

- A- L'IL 4.
- B- Le lymphocyte TCD8.
- C- Le mastocyte.
- D- L'histamine.
- E- La phospholipase A2.

Source: Q4 P2018

12. dans l'exploration de l'hypersensibilité de type I

- A- Hyperéosinophilie permet de poser le diagnostic.
- B- Le test cutané négatif donne une induration d'un diamètre supérieure à celui du contrôle négatif.
- C- L'interrogatoire constitue la première étape dans le diagnostic.
- D- Le test de provocation bronchique est prescrit en 1ere intension.
- E- La recherche des IgE spécifiques de l'allergène est un examen abandonné.

Source: Q5 P2018

13. Parmi les facteurs étiologiques d'hypersensibilité de type I (HSI) :

- A- Le tabac.
- B- Les facteurs climatiques.
- C- Le mode de vie.
- D- Les infections épisodiques.
- E- Les facteurs professionnels.

Source: Q1 EMD3 P2017

14. Parmi les anomalies immunologiques observées au cours de l'HSI :

- A- Altération des lymphocytes régulateurs.
- B- Augmentation de l'interleukine 4.
- C- Augmentation de l'interleukine 5.
- D- Augmentation de l'interféron gamma.
- E- Augmentation de l'interleukine 13.

Source: Q2 EMD3 P2017

15. Parmi les signes cliniques d'allergie alimentaire :

- A- Douleurs abdominales.
- B- Œdème labial.
- C- Urticaire.
- D- Atteintes neurologiques.
- E- Céphalées.

Source: Q3 EMD3 P2017

16. Parmi les paramètres spécifiques du diagnostic d'HSI :

- A- Dosage des IgE spécifiques.
- B- Test d'activation des basophiles.
- C- Dosage de l'histamine.
- D- Test de dégranulation des basophiles.
- E- Test de libération de l'histamine.

Source: Q4 EMD3 P2017

17. Parmi les moyens non spécifiques utilisés dans le traitement de l'HSI :

- A- Anti-estérase.
- B- Corticoïdes.
- C- Antihistaminiques (antiH2).
- D- Stabilisateur membranaire.
- E- Inhibiteurs des leucotriènes.

Source: Q5 EMD3 P2017

18. Parmi les moyens du traitement immunologique de l'HSI :

- A- Désensibilisation.
- B- Anticorps monoclonaux anti IgE.
- C- Anticorps monoclonaux anti IL4.
- D- Stabilisateurs des mastocytes.
- E- Inhibiteurs de TH2.

Source: Q6 EMD3 P2017

19. Parmi les pathologies de l'HSI :

- A- Certaines conjonctivites.
- B- Certaines Rhinites.
- C- Certaines dermatites.
- D- Certaines pharyngites.
- E- Les urticaires impliquant des anticorps fixés sur les mastocytes.

Source: Q7 EMD3 P2017

20. Parmi les médiateurs inflammatoires préformes libérés après l'activation des mastocytes :

- A- Sérotonine.
- B- Chondroïtine sulfate.
- C- Prostaglandines.
- D- Histamine.
- E- Tryptase.

Source: Q8 EMD3 P2017

21. Parmi les cellules impliquées dans le développement de l'HSI :

- A- Lymphocytes B.
- B- Kératinocytes.
- C- Cellules dendritiques.
- D- Lymphocyte T.
- E- Polynucléaires éosinophiles.

Source: Q9 EMD3 P2017

22. Parmi les éléments immunologiques impliqués dans le développement de l'HSI :

- A- Les immunoglobulines G.
- B- Le complément.
- C- Le naturel killer.
- D- Les immunoglobulines A.
- E- Les immunoglobulines M.

Source: Q10 EMD3 P2017

23. Concernant l'hypersensibilité de type I : (la RF)

- A- Les manifestations cliniques apparaissent dans les 5 mn suivant la pénétration de l'allergène dans un organisme pré-sensibilisé.
- B- La demi-vie des IgE spécifiques d'allergènes augmentent après leur fixation sur les cellules.
- C- Les mastocytes, les basophiles, et les éosinophiles sont des acteurs principaux de la phase de sensibilisation.
- D- L'IL-4 et l'IL-13 sont des cytokines importantes pour orienter vers la réponse Th2.
- E- L'histamine pré-stockée dans les granules des cellules constitue un médiateur rapide dans la réaction d'HPS I.

Source: Q7 EMD2 P2014

24. La recherche des IgE spécifiques dans l'hypersensibilité de type I (HPS I) : (la RF)

- A- Se fait par des techniques radioimmunologiques très sensibles.
- B- Permet de confirmer un test cutané positif.
- C- Apporte une aide au diagnostic de l'HPS I surtout si le test cutané n'est pas concluant.
- D- Présente un intérêt majeur notamment avant d'entreprendre une désensibilisation.
- E- Est modifié en cas d'infection parasitaire.

Source: Q8 EMD2 P2014

25. Les Immunoglobulines E : (la RF)

- A- Ce sont des « immunoglobulines, constituées de deux chaînes lourdes et deux chaînes légères κ ou λ , la chaîne lourde possédant un domaine variable et 04 domaines constants.
- B- Sont homocytotropes.
- C- Participent à la réaction allergique en activent le complément.
- D- Ne traversent pas la barrière placentaire.
- E- Possèdent des récepteurs de basophiles exprimés notamment par les monocytes.

Source: Q9 EMD2 P2014

26. À propos des allergènes responsables de l'hypersensibilité type I : (la RF)

- A- Ils activent les lymphocytes B folliculaires.
- B- Ils enrichissent une coopération entre lymphocytes T et B.
- C- Ils sont de nature protéique et sont présentés par des molécules HLA classe II.
- D- Ils sont classés en général en fonction de leur voie de pénétration.
- E- La désensibilisation reste la thérapie la plus utilisée contre les trophallergènes.

Source: Q10 EMD2 P2014

27. Les éléments principaux de la phase de sensibilisation de l'HS I : (la RF)

- A- Les cellules dendritiques.
- B- Les allergènes.
- C- Les plaquettes.
- D- Les lymphocytes T CD4+.
- E- Les mastocytes.

Source: Q11 EMD2 P2014

28. Les médiateurs mésoformes de l'HS I sont : (la RF)

- A- Thromboxane.
- B- Leucotriènes.
- C- Chymase.
- D- Prostaglandines.
- E- Paf-acether.

Source: Q12 EMD2 P2014

29. Parmi les traitements non spécifiques de l'asthme atopique (la RF)

- A- Les antidépresseurs.
- B- Le bronchodilatateur.
- C- Les inhibiteurs des cyclooxygénases.
- D- Les stabilisateurs membranaires.
- E- Les anticorps monoclonaux anti IgE.

Source: Q14 EMD2 P2014

30. Dans l'hypersensibilité immédiate: (La RF)

- A- L'immunoglobuline E est l'effecteur principal de la réaction.
- B- Plusieurs molécules solubles ou membranaires participent au développement de la réaction allergique.
- C- les allergènes en cause activent des lymphocytes B de la zone marginale.
- D- On note une production accrue d'interleukine 4.
- E- On note un déséquilibre TH1/TH2 en faveur des réponses TH2.

Source: Q16 EMD1 P2010

31. Dans l'exploration des états d'HS I: (La RF)

- A- L'anamnèse est un élément très important pour cibler les allergènes.
- B- On effectue un dosage des IgE spécifiques circulantes.
- C- Le test de dé-granulation des basophiles humaines est un test très spécifique.
- D- Les tests cutanés peuvent être pratiqués chez les sujets présentant un dermographisme ou une hypo réactivité cutanée.
- E- L'hyper éosinophilie n'est pas un test spécifique.

Source: Q17 EMD1 P2010

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐
Q3	☐	☐	☐	☐	☐
Q4	☐	☐	☐	☐	☐
Q5	☐	☐	☐	☐	☐
Q6	☐	☐	☐	☐	☐
Q7	☐	☐	☐	☐	☐
Q8	☐	☐	☐	☐	☐
Q9	☐	☐	☐	☐	☐
Q10	☐	☐	☐	☐	☐
Q11	☐	☐	☐	☐	☐
Q12	☐	☐	☐	☐	☐
Q13	☐	☐	☐	☐	☐
Q14	☐	☐	☐	☐	☐
Q15	☐	☐	☐	☐	☐
Q16	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q17	☐	☐	☐	☐	☐
Q18	☐	☐	☐	☐	☐
Q19	☐	☐	☐	☐	☐
Q20	☐	☐	☐	☐	☐
Q21	☐	☐	☐	☐	☐
Q22	☐	☐	☐	☐	☐
Q23	☐	☐	☐	☐	☐
Q24	☐	☐	☐	☐	☐
Q25	☐	☐	☐	☐	☐
Q26	☐	☐	☐	☐	☐
Q27	☐	☐	☐	☐	☐
Q28	☐	☐	☐	☐	☐
Q29	☐	☐	☐	☐	☐
Q30	☐	☐	☐	☐	☐
Q31	☐	☐	☐	☐	☐

6. Hypersensibilité type II

1. Parmi les affections suivantes, quelle est celle qui est classée dans les états d'hypersensibilité de type II ?

- A- L'anémie mégalo-blastique de Biermer,.
- B- L'allergie aux acariens,.
- C- La maladie hémolytique du nouveau-né.
- D- La maladie du poumon de fermier.
- E- La dermatite atopique.

Source: Q6 P2022

2. Les mécanismes lésionnels de l'hypersensibilité de type II incluent :

- A- Le dépôt de complexes immuns circulants.
- B- La cytotoxicité cellulaire par CTL.
- C- La cytotoxicité dépendante du complément (CDC).
- D- La cytotoxicité cellulaire dépendante de l'anticorps (ADCC).
- E- L'opsonisation/phagocytose.

Source: Q7 P2021

3. Au cours de la maladie hémolytique du nouveau-né, on retrouve :

- A- Des anticorps anti-ABO sur les hématies du nouveau-né.
- B- Des anticorps anti-ABO sur les hématies de la mère.
- C- Des anticorps anti-Rhésus sur les hématies du nouveau-né.
- D- Des anticorps anti-Rhésus sur les hématies de la mère.
- E- Des anticorps anti-Rhésus dans le sérum de la mère.

Source: Q8 P2021

4. La maladie hémolytique du nouveau-né (MHN) provoquée par l'incompatibilité Rhésus implique un état d'hypersensibilité de type II qui dépend de :

- A- La phagocytose (Opsonisation).
- B- La Lyse dépendante du complément.
- C- La cytotoxicité dépendante des anticorps (ADCC).
- D- Des anticorps non cytotoxiques.
- E- Des anticorps anti-plaquettes.

Source: Q10 P2020

5. Citer 03 mécanismes immunopathologiques de l'hypersensibilité de type II :

Source: Q2 P2020 RATTRAPAGE

(QROC).

6. parmi les mécanisme des destruction cellulaire au cours de l'hypersensibilité de type II on retrouve :

- A- La cytotoxicité dépendante du complément.
- B- La cytotoxicité médiée par les lymphocytes T CD8+.
- C- La cytotoxicité médiée par les lymphocytes NK.
- D- L'opsonisation-phagocytose.
- E- La cytotoxicité dépendante de l'anticorps (ADCC).

Source: Q6 P2019

7. l'hypersensibilité de type 2 :

- A- Est une réaction médiée par des anticorps de classe IgE.
- B- Peut survenir au cours d'une transfusion sanguine ABO incompatible.
- C- Est due à des complexes immuns circulants.
- D- Se produit en réponse à des Ag cellulaires ou tissulaires.
- E- Fait appel à des lymphocytes TCD8+ cytotoxiques.

Source: Q6 P2018

8. les mécanismes effecteurs impliqués dans les réactions d'hypersensibilité type 2 :

- A- cytotoxicité complément dépendante.
- B- opsonisation et phagocytose.
- C- anaphylaxie.
- D- cytotoxicité anticorps dépendante ADCC.
- E- interaction avec des récepteurs cellulaires et altération de leur fonction.

Source: Q7 P2018

9. le test de coombs indirect permet de mettre en évidence :

- A- L'origine immunologique d'une anémie hémolytique.
- B- L'origine auto immune d'une anémie hémolytique.
- C- L'origine allo immune d'une anémie hémolytique.
- D- La présence d'anticorps anti-érythrocytaires dans le sérum du malade.
- E- La présence d'AC anti-érythrocytaires à la surfaces des hématies du malade.

Source: Q8 P2018

On peut également trouver les informations de cette question dans le cours
< Réaction d'agglutination et d'hémagglutination >

10. la cytotoxicité cellulaire dépendante de l'anticorps ADCC implique :

- A- Les PNN.
- B- Le CD16.
- C- IgG.
- D- Les cellules NK.
- E- LT CD8+.

Source: Q30 P2018

11. Parmi les pathologies de HS II :

- A- Le rejet humoral de greffe.
- B- Toutes les anémies hémolytiques.
- C- Certaines néphropathies.
- D- Thrombopénie Idiopathique.
- E- La maladie Good Pasture (syndrome pneumo-rénal).

Source: Q11 EMD3 P2017

12. Les paramètres à explorer lors de HS II :

- A- Le Système du complément.
- B- Détermination de l'antigène cible.
- C- Processus inflammatoire.
- D- Atteintes organiques et fonctionnelles des organes atteints.
- E- La fonction des lymphocytes T.

Source: Q12 EMD3 P2017

13. A propos de l'hypersensibilité de type II (HPS II) : (Ia RF)

- A- Elle exige des d'isotype IgM et IgG.
- B- Elle fait intervenir toutes les voies d'activation du complément.
- C- Elle implique des cellules effectrice expriment des recepteur pour FCγ.
- D- Les cellules sanguines constituent une cible fréquente dans ce type de réactions.
- E- La maladie de Good Pasture est un exemple d'HPS II dont la cible est exprimée par le rein.

Source: Q5 EMD2 P2014

14. Dans la maladie hémolytique du nouveau né (MHNN) : (1a RF)

- A- L'incompatibilité dans les antigènes du système Rhésus est souvent la cause de cette maladie.
 B- La première grossesse présente un risque faible de MHNN.
 C- La mère Rh- produit des anticorps IgG anti-antigène D qui traversent le placenta.
 D- Le diagnostic se fait par le test de Coombs directe chez le nouveau né et le test de Coombs indirecte chez la mère.
 E- Il n'existe aucun traitement préventif de la maladie, il suffit de surveiller chaque grossesse.

Source: Q6 EMD2 P2014

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐
Q3	☐	☐	☐	☐	☐
Q4	☐	☐	☐	☐	☐
Q5					
Q6	☐	☐	☐	☐	☐
Q7	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q8	☐	☐	☐	☐	☐
Q9	☐	☐	☐	☐	☐
Q10	☐	☐	☐	☐	☐
Q11	☐	☐	☐	☐	☐
Q12	☐	☐	☐	☐	☐
Q13	☐	☐	☐	☐	☐
Q14	☐	☐	☐	☐	☐

7. Hypersensibilité type III

1. Parmi les pathologies suivantes quelles sont celles qui sont dues à des complexes immuns ?

- A- Poumon de fermier.
 B- Pneumonie à pneumocoque.
 C- Vascularite à ANCA.
 D- Néphropathie lupique.
 E- Eczéma atopique.

Source: Q7 P2022

2. L'hypersensibilité de type III est impliquée dans physiopathologies des maladies suivantes :

- A- Le syndrome de Goodpasture.
 B- Les cytopénies médicamenteuses.
 C- La maladie sérique.
 D- Le lupus érythémateux systémique.
 E- La dermatite atopique.

Source: Q9 P2021

3. L'état d'hypersensibilité de type III est provoqué par des complexes anticorps-antigènes de type :

- A- De petits complexes immuns circulants.
 B- De grands complexes immuns.
 C- Des complexes immuns de taille moyenne.
 D- Complexes immuns qui ne peuvent pas être transportés par les globules rouges au système réticulo-endothélial.
 E- Complexes immuns facilement transportés par les globules rouges au système réticulo-endothélial.

Source: Q11 P2020

4. Citer 03 pathologies à hypersensibilité de type III :

Source: Q3 P2020 RATRAPAGE

(QROC).

5. Les réactions d'hypersensibilité de type III :

- A- Font intervenir des anticorps d'isotype IgM ou IgG cytotoxiques.
 B- Sont dues à la formation de complexes immuns .
 C- Sont d'apparition immédiate.
 D- Sont caractérisées par une consommation du complément.
 E- Font intervenir des polynucléaires neutrophiles et des médiateurs vasoactifs .

Source: Q7 P2019

6. Les pathologies suivantes font intervenir des mécanismes d'hypersensibilité de type III :

- A- L'asthme.
 B- L'hépatite virale C.
 C- Le lupus érythémateux disséminé.
 D- La maladie du poumon de fermier.
 E- La maladie de Crohe.

Source: Q8 P2019

7. les réactions d'hypersensibilité de type III

- A- Font intervenir des AC d'isotype IgM ou IgG cytotoxique.
 B- Sont dues à la formation de complexes immuns.
 C- Sont d'apparition immédiate.
 D- Sont caractérisées par une consommation du complément.
 E- Font intervenir des polynucléaires neutrophiles et des médiateurs vasoactifs.

Source: Q9 P2018

8. les pathologies suivantes font intervenir des mécanismes d'hypersensibilité de type III :

- A- L'asthme.
 B- La maladie de goodpasture.
 C- Le lupus érythémateux disséminé.
 D- La maladie de poumon de fermier.
 E- Le choc anaphylactique.

Source: Q10 P2018

9. Concernant HS III :

- A- C'est l'HS semi retardée.
 B- C'est l'HS a complexes immuns.
 C- Elle existe sous deux formes (localisée, systémique).
 D- Elle se développe, surtout, chez les adultes.
 E- Elle est décrite par Arthus.

Source: Q13 EMD3 P2017

10. Parmi les éléments impliqués dans la phase de déclenchement de l'HS III

- A- Chimiokines.
- B- Complément.
- C- Polynucléaires neutrophiles.
- D- Lymphocyte B.
- E- Médiateurs inflammatoires solubles.

Source: Q14 EMD3 P2017

11. Le développement de l'HSIII est favorisé par :

- A- Immunogénicité de l'antigène en cause.
- B- Déficit en protéines du complément.
- C- Déficit en récepteur du complément.
- D- Déficit en récepteurs des parties constantes des immunoglobulines.
- E- Facteurs climatiques.

Source: Q15 EMD3 P2017

12. Les atteintes les plus observées suite au dépôt des complexes circulants :

- A- Rénales.
- B- Articulaires.
- C- Oculaires.
- D- Vasculaires.
- E- Cardiaques.

Source: Q16 EMD3 P2017

13. Parmi les pathologies adoptant les mécanismes de l'HS III :

- A- Pneumonie du fermier.
- B- Glomérulo-néphrite post streptococcique chez l'enfant.
- C- Néphropathie lupique.
- D- Arthralgies réactionnelles post infectieuses.
- E- Neuropathies dégénératives.

Source: Q17 EMD3 P2017

14. L'effet pathogène des complexes immuns :

- A- Est dû à des complexes formés in situ ou dans la circulation.
- B- Peut être dû à des Immunoglobulines de classe IgA dans les réactions de type Arthus pulmonaire.
- C- Est un mécanisme important dans les glomérulonéphrites lupiques.
- D- Est un mécanisme important dans certaines vascularites.
- E- S'observe, en général, avec des Immunoglobulines de classe IgM ou IgG.

Source: Q4 EMD2 P2012

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐
Q3	☐	☐	☐	☐	☐
Q4	☐	☐	☐	☐	☐
Q5	☐	☐	☐	☐	☐
Q6	☐	☐	☐	☐	☐
Q7	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q8	☐	☐	☐	☐	☐
Q9	☐	☐	☐	☐	☐
Q10	☐	☐	☐	☐	☐
Q11	☐	☐	☐	☐	☐
Q12	☐	☐	☐	☐	☐
Q13	☐	☐	☐	☐	☐
Q14	☐	☐	☐	☐	☐

8. Hypersensibilité type IV

1. Concernant la réaction d'hypersensibilité de type IV :

- A- La réaction tuberculinique et la réaction granulomateuse sont de type TH1.
- B- L'activation des éosinophiles via les cytokines IL-4 et IL-5 est une HS4 de type TH17.
- C- L'hypersensibilité granulomateuse est le résultat d'une stimulation continue et chronique d'un lymphocyte B.
- D- Les kératinocytes jouent un rôle central dans l'hypersensibilité de contact en sécrétant de l'IL-10 et TGFβ.
- E- L'hypersensibilité de contact se caractérise par la formation d'un granulome au site de contact avec l'antigène.

Source: Q8 P2022

2. Quel est le principe du test QuantIFERON-TB ?

- A- Il identifie directement la présence de Mycobacterium tuberculosis dans un échantillon de sang.
- B- Il mesure l'intensité de la réponse immunitaire humorale contre Mycobacterium tuberculosis.
- C- Il est utilisé pour le suivi de l'intradermoréaction à la tuberculine à la deuxième visite.
- D- Il quantifie les anticorps anti-tuberculose in vitro.
- E- Il détecte la production d'interféron-gamma par les LT spécifiques des antigènes de Mycobacterium tuberculosis.

Source: Q9 P2022

3. Les éléments impliqués dans une réaction d'hypersensibilité de type IV sont :

- A- Les immunoglobulines IgG.
- B- Les lymphocytes TH1.
- C- Les lymphocytes TH2.
- D- Les lymphocytes T CD8+ cytotoxiques.
- E- Les macrophages.

Source: Q4 P2021

4. Le granulome tuberculeux est composé de : [Cette question a été retirée]

- A- Cellules épithélioïdes.
- B- Cellules multinucléées géantes.
- C- Macrophages.
- D- Lymphocytes T.
- E- Pus caseux.

Source: Q5 P2021

5. Les réactions d'hypersensibilité type IV font intervenir :

- A- Des immunoglobulines IgG.
- B- Des immunoglobulines IgE.
- C- Des lymphocytes TH1.
- D- Des lymphocytes TCD8+ cytotoxiques.
- E- Des macrophages.

Source: Q1 P2021 RATRAPAGE

6. Les cytokines impliquées dans une réaction d'hypersensibilité type IV sont :

- A- IL2.
- B- IL3.
- C- IL17.
- D- IFN γ .
- E- TNF α .

Source: Q2 P2021 RATTRAPAGE

7. Les réactions d'hypersensibilité de type IV sont caractérisées par :

- A- L'apparition de lésions dans un délai de 24 heures.
- B- L'apparition de complexes immuns circulants.
- C- L'intervention d'immunoglobulines d'isotype IgG et IgM.
- D- L'intervention de LT CD8+ cytotoxiques.
- E- L'infiltration des lésions par des macrophages.

Source: Q12 P2020

8. Parmi les affections impliquant des réactions d'hypersensibilité de type IV, on retrouve :

- A- La tuberculose pulmonaire.
- B- L'alvéolite allergique extrinsèque.
- C- La maladie sérique.
- D- la sarcoïdose.
- E- La dermatite de contact.

Source: Q13 P2020

9. L'hypersensibilité de type IV est caractérisée par :

- A- Son Initiation par les LT.
- B- Le délai nécessaire de son installation(48.72h).
- C- L'intervention d'immunoglobuline d'isotype IgG spécifique de l'antigène causal.
- D- L'infiltration tissulaire des lésions par des macrophages.
- E- La sécrétion de cytokines du profil TH2.

Source: Q9 P2019

10. la dermatite de contact :

- A- Est une réaction d'hypersensibilité retardée.
- B- Est due le plus souvent à des antigènes hapténiques.
- C- Est caractérisée par des lésions cutanées granulomateuses.
- D- Fait intervenir des lymphocytes TH1.
- E- Est caractérisée par l'infiltration du site inflammatoire par des polynucléaires neutrophiles.

Source: Q11 P2018

11. la réaction d'hypersensibilité de type IV fait intervenir :

- A- Les lymphocytes B.
- B- Les lymphocytes TH1.
- C- Les lymphocytes TH2.
- D- Les lymphocytes T CD8+.
- E- Le système du complément.

Source: Q12 P2018

12. les pathologies suivantes font intervenir des mécanismes d'hypersensibilité de type IV :

- A- La maladie sérique.
- B- La thyroïdite de basedow.
- C- Le lupus érythémateux disséminé.
- D- La maladie de crohn.
- E- Le rhume des foins.

Source: Q13 P2018

13. A propos de l'HS IV :

- A- C'est une réaction immunitaire cellulaire.
- B- Elle se développe après 48 heures.
- C- Elle est favorisée par le déficit en interféron gamma.
- D- Elle peut se développer les nourrissons.
- E- Il existe un type dépendant de TH 2.

Source: Q18 EMD3 P2017

14. Parmi les lésions dues à l'HS IV :

- A- Granulome tuberculeux.
- B- Silicose.
- C- La réaction à la tuberculine.
- D- Eczéma de contact.
- E- Lésions par les polynucléaires éosinophiles lors de l'HS I.

Source: Q19 EMD3 P2017

15. Parmi les examens exploration de l'HS IV :

- A- Test a tuberculine.
- B- Test du quantiféron.
- C- Dosage des immunoglobulines.
- D- Test d'inhibition des macrophages.
- E- Test de transformation blastique.

Source: Q20 EMD3 P2017

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐
Q3	☐	☐	☐	☐	☐
Q4	☐	☐	☐	☐	☐
Q5	☐	☐	☐	☐	☐
Q6	☐	☐	☐	☐	☐
Q7	☐	☐	☐	☐	☐
Q8	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q9	☐	☐	☐	☐	☐
Q10	☐	☐	☐	☐	☐
Q11	☐	☐	☐	☐	☐
Q12	☐	☐	☐	☐	☐
Q13	☐	☐	☐	☐	☐
Q14	☐	☐	☐	☐	☐
Q15	☐	☐	☐	☐	☐

9. Autoimmunité

1. concernant la tolérance périphérique des LT : (la RF)

- A- Elle implique des mécanismes d'anergie.
- B- La régulation des réponses des Lymphocytes T par des récepteurs inhibiteurs (CTLA-4, PD-1).
- C- L'action des Lymphocytes T régulateurs.
- D- La sélection négative au niveau des organes T lymphoïdes primaires.
- E- L'apoptose des lymphocytes matures via le mécanisme de délétion.

Source: Q13 P2022

2. Concernant l'auto-immunité :

- A- Elle est définie comme une réponse immunitaire dirigée contre les alloantigènes.
- B- Le mécanisme lésionnel n'implique que les auto-anticorps.
- C- La recherche des auto-anticorps est un élément clef pour le diagnostic et le suivi des MAI.
- D- Les auto-antigènes peuvent être spécifiques d'un tissu donné ou bien retrouvés de manière ubiquitaire.
- E- Le lupus érythémateux systémique est le prototype de la pathologie auto-immune spécifique d'organe.

Source: Q14 P2022

3. Une altération d'un gène, parmi les suivants, est responsable de la déficience en lymphocytes T régulateurs Lequel :

- A- AIRE.
- B- CTLA-4.
- C- FOXP3.
- D- FAS.
- E- FCGR1IB.

Source: Q15 P2022

4. Le phénomène de tolérance

- A- Implique des mécanismes centraux et des mécanismes périphériques.
- B- Les mécanismes périphériques impliquent primordialement le gène AIRE.
- C- La tolérance périphérique implique la séquestration des antigènes.
- D- La tolérance périphérique implique la cross-réaction avec des antigènes de l'environnement.
- E- La tolérance centrale consiste en l'élimination des lymphocytes auto-réactifs.

Source: Q13 P2021

5. A propos des maladies auto-immunes :

- A- Peuvent être diagnostiquées par la recherche d'auto-anticorps.
- B- Les connectivites sont des maladies spécifiques d'organes.
- C- Sont retrouvés exclusivement chez les femmes.
- D- Sont subdivisées en maladies spécifiques d'organes et maladies non-spécifiques d'organes.
- E- Sont la conséquence de réponse immunitaire cellulaire et/ou humorale.

Source: Q14 P2021

6. Parmi les caractéristiques des maladies auto-immunes :

- A- Sont présents exclusivement chez le sexe féminin.
- B- Sont diagnostiqués par la recherche des auto-anticorps.
- C- Les lésions sont dues aux mécanismes strictement cellulaires.
- D- Peuvent être spécifiques ou non d'organes.
- E- Sont dues à un excès de tolérance.

Source: Q16 P2021 RATRAPAGE

7. Un gène parmi ceux des molécules suivantes prédispose au développement des maladies auto-immunes, lequel ?

- A- IL1.
- B- Chaîne gamma du récepteur de l'IL2.
- C- CTLA-4.
- D- C5 du complément.
- E- LFA-1.

Source: Q14 P2020

8. Les auto-anticorps suivants sont spécifiques au diabète de type 1 sauf un, lequel ?

- A- Anti-GAD.
- B- Anti-Islet Antigen.
- C- Anti-Zn transporter 8.
- D- Anti-cellules bêta de Langerhans.
- E- Anti-transglutaminases.

Source: Q15 P2020

9. Citer 04 mécanismes étiologiques de l'auto-immunité :

Source: Q4 P2020 RATRAPAGE

(QROC).

10. Les mécanismes impliqués dans le développement des maladies auto-immunes incluent :

- A- Un défaut de la sélection thymique positive des thymocytes.
- B- [... La proposition n'est pas affichée dans le sujet original].
- C- Un mimétisme moléculaire.
- D- La présence d'auto anticorps naturels à des titres élevés.
- E- La libération d'antigènes séquestrés.

Source: Q10 P2019

11. parmi les maladies auto-immunes spécifiques d'organes . on retrouve :

- A- Diabète type I.
- B- Maladie de Basedow.
- C- La maladie coeliaque.
- D- Lupus érythémateux systémique.
- E- La polyarthrite rhumatoïde .

Source: Q11 P2019

12. les autoanticorps pathologiques se distinguent des auto anticorps physiologiques par :

- A- Un titre sérique plus élevé.
- B- Une affinité pour l'auto antigène plus forte.
- C- Un isotype généralement autre que l'igM.
- D- L'absence de mutations somatiques.
- E- L'absence de manifestations cliniques.

Source: Q14 P2018

13. les facteurs favorisant l'apparition des maladies auto immunes sont :

- A- Défaut de sélection positive des lymphocytes T et B au niveau des organes lymphoïdes centraux.
- B- Libération accidentelle d'auto antigènes séquestrés.
- C- La prédisposition familiale.
- D- Le sexe masculin.
- E- Le système HLA.

Source: Q15 P2018

14. au cours du rhumatisme articulaire aigue RAA, l'auto immunisation peut s'expliquer par :

- A- Une rupture de tolérance centrale.
- B- Une rupture de la tolérance périphérique.
- C- Un mimétisme moléculaire.
- D- Une altération d'un épitope préexistant.
- E- Le démasquage d'un épitope caché.

Source: Q16 P2018

15. Parmi les éléments du système immunitaire impliqué dans la tolérance immunitaire périphérique : (la RF)

- A- Lymphocytes T reg.
- B- Lymphocytes TH3.
- C- Lymphocytes Tr.
- D- IL 10.
- E- Interféron gamma.

Source: Q19 EMD2 P2014

16. Une maladie auto-immune peut résulter : (la RF)

- A- De la stimulation du système immunitaire par un virus ayant un épitope croisé avec un auto-antigène.
- B- Du démasquage d'épitopes cryptiques à la surface d'un auto-antigène.
- C- De la rupture de tolérance de lymphocyte B auto-réactifs.
- D- De la rupture de tolérance de lymphocytes T auto-réactifs.
- E- De l'hyperproduction d'auto-anticorps naturels.

Source: Q20 EMD2 P2014

17. Parmi les facteurs étiologiques des maladies auto-immunes :

- A- Altération d'un seul gène.
- B- Polymorphisme allélique.
- C- Infections par certains virus.
- D- Perturbation du statut hormonal.
- E- Exposition aux rayonnements.

Source: Q11 EMD2 P2012

18. Parmi les facteurs impliqués dans la rupture de tolérance vis-à-vis aux constituants du soi :

- A- Mimétisme moléculaire entre certains auto-antigènes et des antigènes viraux.
- B- Activation des clones T paralysés par diminution d'expression des molécules de Co-stimulation.
- C- Expression aberrante des molécules HLA.
- D- Déplétion des clones T régulateurs.
- E- Production importante d'auto-anticorps naturels.

Source: Q12 EMD2 P2012

19. A l'exemple de l'association préférentielle de certaines MAI avec certains allèles HLA, on cite :

- A- Association Maladie coeliaque/HLA-DQ2.
- B- Association Maladie coeliaque/HLA-DQ8.
- C- Association Spondylarthrite ankylosante/HLA-B27.
- D- Association Sclérose en plaque/HLA-BS-peptide Hbs.
- E- Association Polyarthrite Rhumatoïde/allèlesDR4 et DR1 qui partagent l'épitope Q/R-R/K-R-A-A.

Source: Q13 EMD2 P2012

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐
Q3	☐	☐	☐	☐	☐
Q4	☐	☐	☐	☐	☐
Q5	☐	☐	☐	☐	☐
Q6	☐	☐	☐	☐	☐
Q7	☐	☐	☐	☐	☐
Q8	☐	☐	☐	☐	☐
Q9	☐	☐	☐	☐	☐
Q10	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q11	☐	☐	☐	☐	☐
Q12	☐	☐	☐	☐	☐
Q13	☐	☐	☐	☐	☐
Q14	☐	☐	☐	☐	☐
Q15	☐	☐	☐	☐	☐
Q16	☐	☐	☐	☐	☐
Q17	☐	☐	☐	☐	☐
Q18	☐	☐	☐	☐	☐
Q19	☐	☐	☐	☐	☐

10. Deficits Immunitaires

1. A propos du déficit Immunitaire combiné sévère (SCID) T-B-NK+, il:

- A- Se manifeste quelques années après la naissance.
- B- Est dû à un déficit en chaîne gamma commune des cytokines.
- C- Contre-indique tout type de vaccination.
- D- prédispose à des infections par des germes intracellulaires essentiellement.
- E- Touche aussi bien les LT CD4+ que les LT CD8+.

Source: Q11 P2022

2. Les pathologies suivantes sont des déficits immunitaires primitifs sauf une, laquelle ?

- A- Le syndrome de Di-George.
- B- La maladie de Bruton.
- C- Le déficit en HLA DR.
- D- La maladie de Khaler.
- E- Le Leucocyte Adhesion Deficiency (LAD).

Source: Q12 P2022

3. Les déficits immunitaires primitifs :

- A- Sont des maladies héréditaires transmis par des gènes autosomiques et non autosomiques.
- B- Peuvent être la conséquence d'une infection par le VIH.
- C- Touchent l'immunité humorale uniquement.
- D- S'expriment souvent à un âge tardif.
- E- Peuvent toucher plusieurs membres dans la famille.

Source: Q16 P2021

4. Parmi les caractéristiques clinico-biologiques des déficits immunitaires combinés sévères :

- A- La survenue d'infection à germes intracellulaires dès la naissance.
- B- Un nombre de LT normales ou élevé.
- C- Un déficit de l'immunité humorale associé.
- D- Un retard staturo-pondéral associé.
- E- La tolérance des vaccins vivants atténués.

Source: Q17 P2021

5. Parmi les examens de première intention dans l'exploration des déficits immunitaires primitifs :

- A- Le séquençage génétique.
- B- La recherche des mutations par PCR.
- C- La numération formule sanguine (NFS).
- D- L'électrophorèse des protéines sériques.
- E- Le dosage des immunoglobulines sériques.

Source: Q18 P2021

6. Parmi les signes des déficits immunitaires primitifs humoraux :

- A- Infections à répétitions dès la naissance.
- B- Infections touchants les voies aériennes supérieures à germes intracellulaires surtout.
- C- Un taux d'immunoglobulines bas.
- D- Une fraction gammaglobuline diminuée à l'électrophorèse des protéines sériques.
- E- Trouble digestif en cas de déficit humoral en IgA.

Source: Q13 P2021 RATRAPAGE

7. Lequel des déficits immunitaires suivants est un déficit de l'immunité innée :

- A- La maladie de Bruton.
- B- La neutropénie congénitale sévère.
- C- Le déficit en HLA-DR.
- D- Le syndrome d'hyper-IgM.
- E- Le déficit en sous-classes des IgG.

Source: Q14 P2021 RATRAPAGE

8. A propos de l'exploration génétique des déficits immunitaires primitifs :

- A- Permet de poser un diagnostic de certitude de la maladie.
- B- Se fait en première intention lors de l'exploration.
- C- Peut être utilisé pour le dépistage d'autres cas dans la famille.
- D- N'est recommandé qu'en cas de déficits de l'immunité innée.
- E- Se pratique sur l'ADN du patient.

Source: Q15 P2021 RATRAPAGE

9. Les déficits immunitaires primitifs peuvent se manifester par :

- A- Des infections à répétition.
- B- Des maladies auto-immunes.
- C- Des cancers.
- D- Une protection immune contre les virus respiratoires.
- E- Une protection immune contre les virus à tropisme neurologique.

Source: Q16 P2020

10. Les déficits immunitaires combinés sévères (SCID) peuvent impliquer :

- A- L'absence du lymphocyte T.
- B- L'absence du lymphocyte T et du lymphocyte B.
- C- L'absence du lymphocyte T et du lymphocyte NK.
- D- La présence du lymphocyte T mais absence des polynucléaires neutrophiles.
- E- La présence du lymphocyte T avec présence des polynucléaires neutrophiles.

Source: Q17 P2020

11. Un déficit immunitaire humoral est plutôt suspecté :

- A- Quand le début des infections est dans les premiers six mois de la naissance.
- B- Quand les germes responsables des infections sont de types pyogènes extra-cellulaires.
- C- Quand la localisation des infections est surtout dans la sphère ORL et les poumons.
- D- Quand les germes responsables des infections sont de types intracellulaires obligatoires.
- E- Quand le début des infections est après l'âge de six mois.

Source: Q18 P2020

12. Citer 03 déficits immunitaires primitifs à transmission liée au sexe:

Source: Q8 P2020 RATRAPAGE

(QROC).

13. Citer 04 gènes dont la mutation causerait un déficit immunitaire combiné sévère :

Source: Q9 P2020 RATRAPAGE

(QROC).

14. La granulomatose septique chronique :

- A- Est un déficit immunitaire combiné .
- B- Touche plus souvent les garçons que les filles.
- C- Est due à un déficit en peroxyde dismutase .
- D- Le diagnostic est posé par la réalisation d'un hémogramme.
- E- Est traitée par des immunoglobulines intraveineuses.

Source: Q12 P2019

15. Parmi les déficits immunitaires primitifs humoraux:

- A- Le syndrome de DI-George.
- B- Le déficit en RAG-1/RAG-2.
- C- Le déficit en IgA.
- D- Le déficit en sous classes des IgG.
- E- La maladie de Bruton.

Source: Q13 P2019

16. a propos des déficits immunitaires primitifs :

- A- Sont des pathologies rares.
- B- Sont liés à des anomalies génétiques.
- C- S'expriment le plus souvent à l'âge adulte.
- D- Sont rares dans les populations à forte consanguinité.
- E- Peuvent toucher les cellules ou les molécules du système immunitaire.

Source: Q17 P2018

17. les déficits immunitaires combinés :

- A- Se manifestent cliniquement 6 mois après la naissance.
- B- Ne constituent pas une contre indication pour les vaccins vivants atténués.
- C- Donnent souvent des infections à germes intracellulaire.
- D- Peuvent donner des lymphopénies.
- E- Le déficit en IgA en fait partie.

Source: Q18 P2018

18. a propos des déficits de l'immunité humorale :

- A- Donnent des infections à des germes extracellulaires.
- B- Donnent des infections de la sphère ORL.
- C- L'agammaglobulinémie liée au sexe en fait partie.
- D- Sont exprimés dès la naissance.
- E- Peuvent toucher les classes et les sous classes des immunoglobulines.

Source: Q19 P2018

19. la maladie de bruton :

- A- Est un déficit immunitaire primitif combiné.
- B- Est transmise selon le mode autosomique récessif.
- C- Est caractérisée par l'absence de lymphocytes B circulants.
- D- Est caractérisée par la survenue d'infections dès la naissance.
- E- Est due à une mutation du gène codant la chaîne mu.

Source: Q20 P2018

20. A propos des déficits immunitaires primitifs (DIP) :

- A- Sont des maladies rares.
- B- Sont tous à transmission autosomique récessive.
- C- S'accompagne par des infections à répétition.
- D- Se manifeste généralement dès l'enfance.
- E- Touche préférentiellement la réponse immunitaire adaptative.

Source: Q1 EMD3 P2016

21. Les déficits immunitaires à prédominance humorale se caractérise par :

- A- Des infections à répétition touchant la sphère ORL.
- B- Se manifestent après les 6 premiers mois de la naissance.
- C- Une absence totale des cellules souches hématopoïétiques.
- D- Des infections préférentielles par des bactéries du genre Neisseria.
- E- Une prédominance masculine.

Source: Q2 EMD3 P2016

22. Le syndrome de Di George :

- A- Est un déficit immunitaire à transmission liée au sexe.
- B- Marqué par l'absence totale ou partielle du thymus.
- C- Peut s'accompagner d'une atteinte cardiaque.
- D- Le nombre de LT est généralement réduit.
- E- Contient des troubles de la voie classique du complément.

Source: Q3 EMD3 P2016

23. Les affections suivants sont classées dans les déficits de l'immunité innée :

- A- La granulomatose septique chronique.
- B- La neutropénie congénitale.
- C- Le LAD (Leucocyte adhesion deficiency).
- D- La neutropénie cyclique.
- E- Le syndrome de Wiskott Aldrich.

Source: Q4 EMD3 P2016

24. Dans le bilan diagnostique des déficits immunitaires primitifs on retrouve :

- A- La recherche des protéines monoclonales.
- B- La formule numération sanguine (FNS).
- C- Le dosage des IgE spécifiques des pneumallergènes.
- D- Le dosage des protéines du complément.
- E- La recherche des mutations génétiques.

Source: Q5 EMD3 P2016

25. Les déficits immunitaires combinés sévères (SCID) :

- A- Se caractérisent par des infections à germes intracellulaires dès la naissance.
- B- Peuvent toucher les filles et les garçons.
- C- Sont classés dans les déficits de l'immunité humorale.
- D- Le déficit en enzymes de recombinaison RAG1 et RAG2 est un SCID T-B-NK+.
- E- Ont souvent un très bon pronostic.

Source: Q6 EMD3 P2016

26. Le déficit en HLA II :

- A- Est un déficit d'expression des molécules HLA II.
- B- fréquente dans le bassin méditerranéen.
- C- Entraîne une diminution des LT CD8+.
- D- Est associé dans 80 % des cas à une sérologie HIV+.
- E- Est un déficit immunitaire primitif non classé.

Source: Q7 EMD3 P2016

27. le SIDA :

- A- Stade précoce de l'infection par le VIH.
- B- induit un déficit profond de l'immunité cellulaire.
- C- la survenue d'infections opportunistes est en fonction du taux des LT CD4+.
- D- se transmet selon deux modes dont la transmission verticale est la plus fréquente.
- E- le sarcome de Kaposi est une affection tumorale fréquente dans l'infection par le VIH.

Source: Q8 EMD3 P2016

28. le VIH :

- A- Retrovirus, existant sous deux types.
- B- Pénètre dans la cellule via le CD4 et des récepteurs de cytokines "CCR5 et CXCR4.
- C- L'infection des LTCD4+ se fait grâce aux antigènes matriciels gp41 et gp120.
- D- La cellule dendritique joue un rôle dans la dissémination de l'infection.
- E- La réponse humorale est protectrice et efficace durant la primo-infection.

Source: Q9 EMD3 P2016

29. dans le stade SIDA maladie :

- A- Il y a une altération profonde de la réponse des LT CD8+.
- B- une candidose oesophagienne est très évocatrice.
- C- Les LT CD4+ diminuent au dessous de 200 cellules/mm3.
- D- L'antigénémie p24 est indétectable.
- E- Le malade est séronegatif.

Source: Q10 EMD3 P2016

30. A propos des déficits immunitaires primitifs (DIP) : (la RF)

- A- Ils sont des maladies héréditaires à transmissions souvent autosomique récessive.
- B- Ils sont des maladies rares à expression souvent précoce.
- C- Les déficits de l'immunité humorale sont les plus fréquents parmi les DIP.
- D- Ils sont tous détectés dès la naissance.
- E- Le type et la période de survenu des infections sont des éléments clé dans le diagnostic des DIP.

Source: Q1 EMD2 P2014

31. Les SCID (déficits immunitaires combinés sévères) : (la RF)

- A- Sont des DIP à pronostic sombre.
- B- Sont caractérisés par l'altération des Lymphocytes T.
- C- Leur majorité a une transmission héréditaire liée au sexe.
- D- Les patients peuvent développer des signes de GVHD.
- E- Se caractérisent par la survenue d'infections sévères à répétition dès la naissance.

Source: Q2 EMD2 P2014

32. Les DIP suivants font partie des déficits de l'immunité innée : (la RF)

- A- Le déficit en molécules d'HLA II.
- B- La neutropénie congénitale sévère.
- C- La granulomateuse septique chronique.
- D- Le déficit en CD18.
- E- Le Déficit du c3 du complément.

Source: Q3 EMD2 P2014

33. Concernant le diagnostic des DIP : (la RF)

- A- Il nécessite un interrogatoire minutieux.
- B- Des infections survenant à la naissance font évoquer un déficit de l'immunité humorale.
- C- Des infections à la Neisseria orientent vers un déficit des protéines du système du complément.
- D- L'électrophorèse des protéines sériques est paramètre important de déficits humoraux.
- E- Le diagnostic précoce présente toujours un intérêt pour le pronostic de ces maladies.

Source: Q4 EMD2 P2014

34. Le syndrome d'hyper IgM :

- A- Est un déficit immunitaire primitif pouvant être lié au sexe.
- B- Est dû à un déficit de la commutation isotypique des (switch).
- C- Est caractérisé par une atteinte du CD40L des lymphocytes T.
- D- Est caractérisé par une atteinte du CD40 des lymphocytes B.
- E- Est dû à une mutation de la Btk.

Source: Q5 EMD2 P2012

35. La granulomatose septique chronique :

- A- Se caractérise par une perturbation du test au nitrobleu tétrazolium.
- B- Un déficit d'un composant de la NADPH oxydase.
- C- S'accompagne de pyodermites à staphylocoques.
- D- Est due à une anomalie de la NADH oxydase.
- E- Est dans certains cas une affection liée au sexe.

Source: Q6 EMD2 P2012

36. Les déficits suivant peuvent être à transmission liée au sexe :

- A- La maladie de Bruton.
- B- Le syndrome d'hyper IgM.
- C- Le déficit en adénosine désaminase.
- D- Le déficit combiné sévère par déficit de la chaîne CD132.
- E- Syndrome de Wiskott-Aldrich.

Source: Q7 EMD2 P2012

37. Les déficits suivants sont des déficits à prédominance humoral :

- A- Le déficit en IgA.
- B- Le déficit immunitaire commun variable (CVID).
- C- Le déficit en sous classe des immunoglobulines.
- D- Le syndrome de Wiskott Aldrich.
- E- Le déficit en CD40 dans le syndrome d'hyper-IgM.

Source: Q10 EMD2 P2012

38. Au cours de l'infection par le VIH, la déplétion des lymphocytes T CD4+ est la conséquence de :

- A- Leur élimination par apoptose.
- B- L'effet pathogénique direct du virus).
- C- Leur phagocytose par les macrophages).
- D- Leur élimination par les cellules cytotoxiques.
- E- Leur destruction par une réaction de type ADCC.

Source: Q16 EMD2 P2012

39. Le suivi biologique de l'infection par le VIH peut être réalisé par :

- A- La numération des lymphocytes T CD4+.
- B- Le dosage des immunoglobulines sériques.
- C- L'évaluation du rapport T CD4+/T CD8+.
- D- Le dosage de la protéine virale P24.
- E- L'évaluation du nombre de copie d'ARN viral.

Source: Q17 EMD2 P2012

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐
Q3	☐	☐	☐	☐	☐
Q4	☐	☐	☐	☐	☐
Q5	☐	☐	☐	☐	☐
Q6	☐	☐	☐	☐	☐
Q7	☐	☐	☐	☐	☐
Q8	☐	☐	☐	☐	☐
Q9	☐	☐	☐	☐	☐
Q10	☐	☐	☐	☐	☐
Q11	☐	☐	☐	☐	☐
Q12					
Q13					
Q14	☐	☐	☐	☐	☐
Q15	☐	☐	☐	☐	☐
Q16	☐	☐	☐	☐	☐
Q17	☐	☐	☐	☐	☐
Q18	☐	☐	☐	☐	☐
Q19	☐	☐	☐	☐	☐
Q20	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q21	☐	☐	☐	☐	☐
Q22	☐	☐	☐	☐	☐
Q23	☐	☐	☐	☐	☐
Q24	☐	☐	☐	☐	☐
Q25	☐	☐	☐	☐	☐
Q26	☐	☐	☐	☐	☐
Q27	☐	☐	☐	☐	☐
Q28	☐	☐	☐	☐	☐
Q29	☐	☐	☐	☐	☐
Q30	☐	☐	☐	☐	☐
Q31	☐	☐	☐	☐	☐
Q32	☐	☐	☐	☐	☐
Q33	☐	☐	☐	☐	☐
Q34	☐	☐	☐	☐	☐
Q35	☐	☐	☐	☐	☐
Q36	☐	☐	☐	☐	☐
Q37	☐	☐	☐	☐	☐
Q38	☐	☐	☐	☐	☐
Q39	☐	☐	☐	☐	☐

11. Syndromes Lymphoprolifératifs

1. Tous les signes suivants doivent faire rechercher un myélome multiple sauf un, lequel ?

- A- Un composant monoclonal à l'électrophorèse des protéines sériques.
- B- Une fracture spontanée chez le sujet âgé.
- C- La mise en évidence de lésions osseuses lytiques à l'imagerie.
- D- Une hypercalcémie chez le sujet âgé.
- E- Une polyarthralgie chez l'adulte jeune.

Source: Q16 P2022

2. La protéinurie de Bence-Jones :

- A- Est constituée d'alumine.
- B- Est constituée d'IgG.
- C- Est constituée d'albumine + IgG.
- D- Est constituée de chaînes légères d'immunoglobulines monoclonales.
- E- Est constituée de chaînes légères d'immunoglobulines polyclonales.

Source: Q17 P2022

3. Les gammopathies monoclonales :

- A- Sont le résultat d'une multiplication polyclonales de plasmocytes malins.
- B- Sont des hémopathies malignes touchant principalement la lignée myéloïdes T.
- C- Sont considérées comme des syndromes lymphoprolifératifs.
- D- Peuvent être accompagnées de la présence d'une Ig monoclonale entière dans le sérum.
- E- Le mécanisme physiopathologique implique une hypersensibilité de type IV.

Source: Q15 P2021

4. Les symptômes du myélome multiple incluent :

- A- Une anémie.
- B- Une hypercalcémie.
- C- Une hépatosplénomégalie.
- D- Un syndrome hémorragique.
- E- Une insuffisance rénale.

Source: Q11 P2021 RATRAPAGE

5. Les signes biologiques rencontrés au cours de la maladie de Waldenström incluent :

- A- Une VS accélérée.
- B- Un composant monoclonal d'isotype IgG le plus souvent.
- C- Thrombopénie.
- D- Cryoglobulinémie.
- E- Facteur rhumatoïde.

Source: Q12 P2021 RATRAPAGE

6. Quels sont les signes évocateurs d'un myélome multiple ?

- A- La présence d'une immunoglobuline monoclonale au niveau sérique et/ou urinaire.
- B- Un syndrome tumoral.
- C- Une anémie.
- D- Une insuffisance rénale.
- E- Un syndrome hémorragique.

Source: Q20 P2020

7. Quels sont les signes évocateurs d'une macroglobulinémie de Waldenström ?

- A- La présence d'une immunoglobuline monoclonale non-IgG.
- B- Un syndrome tumoral.
- C- Des lésions osseuses.
- D- Une cryoglobulinémie de type II.
- E- Un syndrome hémorragique.

Source: Q21 P2020

8. Les gammopathies monoclonales de signification indéterminée sont :

- A- Les plus fréquentes des gammopathies monoclonales.
- B- Caractérisées par une prolifération plasmocytaire maligne.
- C- Asymptomatiques.
- D- Rarement accompagnées d'une protéinurie de Bence-Jones.
- E- Susceptibles de se transformer en myélome multiple.

Source: Q22 P2020

9. Citer 04 signes biologiques d'une macroglobulinémie de Waldenström :

Source: Q11 P2020 RATRAPAGE

(QROC).

10. Les signes biologiques suivants peuvent être rencontrés dans la maladie de Kahler :

- A- Une hypogammaglobulinémie.
- B- Un composant monoclonal IgM 19.
- C- Une augmentation de l'urée et de créat dans le sang .
- D- La présence d'une chaîne légère monoclonale dans les urines.
- E- L'augmentation de la concentration de l'albumine sérique .

Source: Q15 P2019

11. La maladie de Waldenström :

- A- Est une immunoglobulinopathie monoclonal de signification indéterminée .
- B- Se caractérise par des symptômes d'hyperviscosité sanguine.
- C- Se caractérise par la présence d'hématies en rouleaux au frottis sanguin.
- D- Est plus fréquente chez les sujets âgés.
- E- Est diagnostiquée par un examen d'immuno-sélection .

Source: Q16 P2019

12. La présence d'un composant monoclonal à l'électrophorèse des protéines sériques est retrouvée dans:

- A- Le sérum de tous les sujets âgés de plus de 70 ans.
- B- Myélome multiple sécrétant a IgG.
- C- Transitoirement dans certaines infections chroniques.
- D- La macroglobulinémie de Waldenström.
- E- Gammopathies monoclonales de signification indéterminée ou MGUS.

Source: Q15 EMD3 P2016

13. Ces paramètres orientent vers le diagnostic du myélome multiple:

- A- Des lésions osseuses associées à une hypercalcémie.
- B- Présence d'un composant monoclonal à l'électrophorèse des protéines sériques.
- C- L'absence de protéinurie de Bence-jones.
- D- Une Plasmocytose médullaire inférieure à 2 %.
- E- Des adénopathies et une splénomégalie.

Source: Q16 EMD3 P2016

14. La Maladie de Waldenstrom:

- A- Est une hémopathie bénigne.
- B- Le composant monoclonal est une IgM 7s monomérique.
- C- Survient généralement chez les sujets âgés.
- D- S'accompagne d'une prolifération plasmocytaire exclusivement médullaire.
- E- S'accompagne d'une hépatosplénomégalie et d'une diminution de la viscosité sanguine.

Source: Q17 EMD3 P2016

15. A propos des gammopathies monoclonales :

- A- La prévalence diminue avec l'âge.
- B- Plus fréquentes chez les femmes que les hommes.
- C- Reflètent toujours un processus malin.
- D- Peuvent être secondaires à des maladies auto-immunes.
- E- S'accompagne toujours de la sécrétion d'un composant monoclonal.

Source: Q18 EMD3 P2016

16. Les pathologies suivantes sont des gammopathies monoclonales :

- A- La maladie des chaînes lourdes alpha.
- B- L'amylose.
- C- L'ataxie télangiectasie.
- D- La leucémie lymphoïde chronique B (LLC B).
- E- Le lymphome malin non hodgkinien.

Source: Q19 EMD3 P2016

17. Parmi les complications du myélome multiple :

- A- L'insuffisance rénale.
- B- L'amylose AL.
- C- Leucémie à plasmocytes.
- D- Leucémie myéloïde aiguë.
- E- Les infections.

Source: Q20 EMD3 P2016

18. Quoi demander devant une suspicion d'un myélome multiple :

- A- Une électrophorèse des protéines sériques et urinaires.
- B- Une ponction à la recherche d'une plasmocytose médullaire.
- C- Une formule de numération sanguine à la recherche d'une leucopénie.
- D- Dosage de la calcémie.
- E- Une radiologie à la recherche de géodes osseuses.

Source: Q8 EMD2 P2012

19. Un pic monoclonal à l'EPP, fait suspecté:

- A- Un myélome multiple.
- B- Infection virale chronique.
- C- MGUS.
- D- Syndrome de Goodpasture.
- E- Maladie de waldenström.

Source: Q9 EMD2 P2012

20. Parmi les examens immunologiques importants pour étayer le diagnostic d'un myelome des os :

- A- L'électrophorèse des protéines sériques.
- B- L'immunofixation sérique.
- C- La recherche de la protéine de bence jones.
- D- L'immunosélecton.
- E- L'évaluation de l'infiltrat plasmocytaire médullaire : myelogramme.

Source: Q18 EMD2 P2012

21. Parmi les caractéristiques des gammopathies de signification indéterminé (MGUS) :

- A- Le taux du composant monoclonal est inférieur à 30g/l.
- B- La calcémie est normale.
- C- La protéinurie des 24 heures ne présente pas d'anomalies.
- D- L'hémogramme est normal.
- E- L'électrophorèse de protéine sérique est normale.

Source: Q19 EMD2 P2012

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐
Q3	☐	☐	☐	☐	☐
Q4	☐	☐	☐	☐	☐
Q5	☐	☐	☐	☐	☐
Q6	☐	☐	☐	☐	☐
Q7	☐	☐	☐	☐	☐
Q8	☐	☐	☐	☐	☐
Q9					
Q10	☐	☐	☐	☐	☐
Q11	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q12	☐	☐	☐	☐	☐
Q13	☐	☐	☐	☐	☐
Q14	☐	☐	☐	☐	☐
Q15	☐	☐	☐	☐	☐
Q16	☐	☐	☐	☐	☐
Q17	☐	☐	☐	☐	☐
Q18	☐	☐	☐	☐	☐
Q19	☐	☐	☐	☐	☐
Q20	☐	☐	☐	☐	☐
Q21	☐	☐	☐	☐	☐

12. Transplantation (Grefe)

1. Dans le rejet Hyper_aigu d'une greffe rénale :

- A- Le greffon est rejeté une semaine après la greffe.
- B- Le traitement consiste en une dé-transplantation d'urgence.
- C- Le rejet est évité à 100% si on respecte la compatibilité ABO.
- D- Le système du complément est fortement impliqué dans les mécanismes de rejet.
- E- Les mécanismes de l'immunité cellulaire y sont impliqués.

Source: Q10 P2022

2. Le rejet d'une deuxième greffe de peau provenant du même donneur allogénique : (La RF)

- A- Peut être bloqué par l'azathioprine (un agent antimitotique).
- B- Procède à la même vitesse que le premier rejet de greffon.
- C- Montre une spécificité pour le donneur de greffon.
- D- Peut être transféré à un receveur naïf porteur de lymphocytes.
- E- Implique la reconnaissance des différences en matière de CMH.

Source: Q10 P2021

3. La maladie du greffon contre l'hôte accompagne souvent la transplantation de :

- A- Cartilage.
- B- Rein.
- C- Moelle osseuse.
- D- Cœur.
- E- Pancréas.

Source: Q11 P2021

4. Le rejet hyper aigu de greffe rénale est dû à :

- A- Des anticorps anti-HLA préformés spécifiques du donneur.
- B- Des lymphocytes T CD4.
- C- Lymphocytes T CD8.
- D- Des plaquettes.
- E- Des complexes immuns circulants.

Source: Q12 P2021

5. Dans la greffe de moelle osseuse, le phénomène le plus souvent rencontré :

- A- Le rejet de greffe par le receveur.
- B- La réaction du greffon contre l'hôte (GVH).
- C- L'effet GVL (réaction du greffon contre la leucémie).
- D- L'hypersensibilité de type I.
- E- L'hypersensibilité de type III.

Source: Q17 P2021 RATRAPAGE

6. Le rejet hyper aigu de greffe rénale est dû à :

- A- Des anticorps anti-ABO chez le receveur.
- B- Des lymphocytes T CD4 $\gamma\delta$.
- C- Lymphocytes pré-cytotoxiques.
- D- Des mastocytes avec une réaction d'hypersensibilité de type I.
- E- Des anticorps anti-HLA préformés spécifiques du donneur.

Source: Q18 P2021 RATRAPAGE

7. Le dysfonctionnement chronique du greffon (rejet chronique) :

- A- Est un rejet mixte : cellulaire et humoral.
- B- Est dû uniquement aux antigènes du système HLA.
- C- Se traduit par le rétrécissement du diamètre des artères rénales.
- D- Il y a une diminution de la sécrétion du VEGF (facteur de croissance de l'endothélium vasculaire) par les cellules endothéliales.
- E- Son risque augmente avec la présence de maladies chroniques comme l'HTA et les dyslipidémies.

Source: Q19 P2020

8. Citer 04 événements immunisants causant l'apparition d'anticorps anti-HLA:

Source: Q10 P2020 RATRAPAGE

(QROC).

9. A Propos du rejet hyper aigu de la greffe rénale:

- A- Il est strictement à médiation humorale.
- B- Il est dû à des anticorps préformés et néoformés anti-HLA.
- C- Il survient quelques jours après la greffe rénale.
- D- La détransplantation est réalisée en urgence.
- E- Le système du complément joue un rôle important dans ce rejet.

Source: Q14 P2019

10. La présentation directe des allo antigènes au cours d'une transplantation rénale : (la RF)

- A- Met en jeu les cellules dendritiques du donneur.
- B- Joue un rôle majeur dans le rejet chronique.
- C- Cette reconnaissance n'est pas restreinte par le CMH autologue.
- D- Est à l'origine de la première vague de stimulation antigénique.
- E- Se fait au niveau de la rate.

Source: Q13 EMD2 P2014

11. La prévention du rejet d'allogreffe : (la RF)

- A- Nécessite une connaissance de l'histocompatibilité entre donneur et receveur.
- B- La compatibilité ABO est un critère obligatoire.
- C- Le rejet hyper aigu est accessible aux traitements immunosuppresseurs.
- D- La bonne compatibilité HLA diminue la fréquence des crises de rejet.
- E- Le cross match pré transplantation permet d'éviter la survenue de rejet hyper aigu.

Source: Q15 EMD2 P2014

12. Le bilan immunologique effectué en pré transplantation rénale comporte : (la RF)

- A- La recherche des agglutinines irrégulières.
- B- Typage HLA du receveur et du donneur.
- C- Recherche d'anticorps anti HLA.
- D- Recherche de DSA.
- E- Le cross match.

Source: Q16 EMD2 P2014

13. Dans la transplantation rénale allo génique: (La RF)

- A- Le devenir du transplant dépend entre autre de la réaction immunitaire du receveur contre des antigènes majeurs d'histocompatibilité exprimés chez le donneur.
- B- L'épreuve de cross match est une réaction in vitro entre les cellules du receveur et le sérum du donneur.
- C- La connaissance de l'histocompatibilité entre donneur et receveur est primordiale.
- D- Pour les patients en post-transplantation, la détection précoce des anticorps anti HLA induits par le greffon sont le signe d'un rejet humoral anticorps médié.
- E- La présentation directe des allo antigènes chez le receveur est à l'origine de la première vague de stimulation allo génique.

Source: Q20 EMD1 P2010

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐
Q3	☐	☐	☐	☐	☐
Q4	☐	☐	☐	☐	☐
Q5	☐	☐	☐	☐	☐
Q6	☐	☐	☐	☐	☐
Q7	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q8	☐	☐	☐	☐	☐
Q9	☐	☐	☐	☐	☐
Q10	☐	☐	☐	☐	☐
Q11	☐	☐	☐	☐	☐
Q12	☐	☐	☐	☐	☐
Q13	☐	☐	☐	☐	☐

13. Immunothérapie & Immunosuppression

1. Les vaccins vivants atténués utilisés en Algérie incluent :

- A- Le BCG.
- B- Le DTCoq (Diphtérie, Tétanos, Coqueluche).
- C- Le ROR (Rougeole, Oreillons, Rubéole).
- D- Le vaccin anti-grippal.
- E- Le vaccin anti-polio injectable.

Source: Q18 P2022

2. Les vaccins à vecteurs viraux :

- A- Produisent des réponses humorales.
- B- Produisent des réponses cellulaires.
- C- Nécessitent généralement plusieurs rappels.
- D- Nécessitent l'utilisation d'adjuvants.
- E- Sont déconseillés chez la femme enceinte et le sujet immunodéprimé.

Source: Q19 P2022

3. Les anticorps monoclonaux sont :

- A- Dirigés contre un déterminant antigénique unique.
- B- Produits par hyper-immunisation chez l'animal.
- C- Actifs sur un large éventail de cibles moléculaires.
- D- Caractérisés par leur haute spécificité.
- E- Peuvent être d'origine humaine.

Source: Q20 P2022

4. Les vaccins vivants atténués :

- A- Sont produits par traitement de la souche pathogène par la chaleur ou par des agents chimiques.
- B- Produisent une mémoire immunitaire cellulaire.
- C- Produisent une mémoire immunitaire humorale.
- D- Nécessitent généralement des rappels.
- E- Sont contre-indiqués chez la femme enceinte et le sujet immunodéprimé.

Source: Q19 P2021

5. Les vaccins complets inactivés :

- A- Sont préparés par culture prolongée dans des conditions non-favorables.
- B- Produisent principalement des réponses immunitaires humorales.
- C- Gardent leur capacité de croissance après inoculation à l'hôte.
- D- Nécessitent généralement des rappels.
- E- Sont contre-indiqués chez la femme enceinte et le sujet immunodéprimé.

Source: Q20 P2021

6. Les immunoglobulines intraveineuses (IgIV) :

- A- Sont des immunoglobulines monoclonales d'origine murine.
- B- Sont des immunoglobulines monoclonales chimériques.
- C- Sont des immunoglobulines monoclonales d'origine humaine.
- D- Sont des immunoglobulines polyclonales d'origine humaine.
- E- Sont des immunoglobulines polyclonales d'origine animale.

Source: Q21 P2021

7. Le Daclizumab, anticorps monoclonal anti-CD25 :

- A- Est un anticorps monoclonal humanisé.
- B- Est produit par la technique d'hybridation lymphocytaire.
- C- Inhibe le signal transduit par le complexe TCR/CD3.
- D- Inhibe un signal de costimulation du LT.
- E- Inhibe la prolifération du LT.

Source: Q22 P2021

8. Les vaccins inactivés :

- A- Sont préparés par traitement des souches vaccinales par la chaleur ou des agents chimiques.
- B- Permettent le développement de réponses immunitaires cellulaires et humorales.
- C- Sont contre-indiqués chez la femme enceinte et les sujets immunodéprimés.
- D- Le vaccin BCG en est un exemple.
- E- Nécessitent des rappels.

Source: Q8 P2021 RATRAPAGE

9. Les sérums thérapeutiques polyvalents :

- A- Confèrent une protection immunitaire active.
- B- Peuvent être d'origine humaine.
- C- Sont dirigés contre plusieurs spécificités antigéniques.
- D- Sont produits par hybridation lymphocytaire.
- E- Sont d'efficacité durable dans le temps.

Source: Q9 P2021 RATRAPAGE

10. Le Tacrolimus :

- A- Est un immunosuppresseur agissant sur le 2ème signal d'activation du LT.
- B- Inhibe la calcineurine.
- C- Se lie à un récepteur intracellulaire commun avec la rapamycine.
- D- Agit par destruction des cellules proliférantes.
- E- Agit par inhibition du signal de prolifération du LT.

Source: Q10 P2021 RATRAPAGE

11. Les vaccins vivants atténués :

- A- Sont obtenus par traitement de l'agent pathogène par la chaleur ou des solvants organiques.
- B- Perdent leur pathogénicité.
- C- Conservent leur capacité de croissance chez l'hôte.
- D- Nécessitent plusieurs rappels.
- E- Nécessitent l'utilisation d'adjuvants.

Source: Q23 P2020

12. La sélection des hybridomes pour la production des anticorps monoclonaux fait appel à :

- A- Des lignées lymphocytaires B porteuses de déficits enzymatiques.
- B- Des lignées myélomateuses porteuses de déficits enzymatiques.
- C- Des lignées lymphocytaires B non-sécrétrices d'immunoglobulines.
- D- Des lignées myélomateuses non-sécrétrices d'immunoglobulines.
- E- Des souris transgéniques pour les gènes des immunoglobulines.

Source: Q24 P2020

13. Les immunosuppresseurs agissant sur le 3ème signal d'activation des lymphocytes T incluent :

- A- Le Tacrolimus.
- B- Le CTLA4-Ig.
- C- Les anti-CD25.
- D- Les glucocorticoïdes.
- E- La Rapamycine.

Source: Q25 P2020

14. Citer 04 immunosuppresseurs ciblant le LT :

Source: Q5 P2020 RATRAPAGE

15. Citer 02 avantages des vaccins vivants atténués :

Source: Q6 P2020 RATRAPAGE

16. Citer 02 inconvénients des vaccins vivants atténués:

Source: Q7 P2020 RATRAPAGE

(QROC 14, 15, 16).

17. Les vaccins complets inactivés:

- A- Sont préparés par culture prolongée dans des conditions non-favorable.
- B- Gardent leur capacité de croissance après inoculation à l'hôte.
- C- Nécessitent des rappels.
- D- Sont contraindiqués chez la femme enceinte et le sujet immunodéprimés.
- E- Produisent principalement des réponses immunitaires humorales.

Source: Q17 P2019

18. Le Daclizumab, anticorps monoclonal anti CD25:

- A- Est un anticorps monoclonal chimérique.
- B- Est produit par la technique d'hybridation phagocytaire.
- C- Est un Immunosuppresseur agissant sur le 2ème signal d'activation des LT.
- D- Inhibe le signal transduit par le TCR.
- E- Inhibe le signal de prolifération de LT.

Source: Q18 P2019

19. la modulation thérapeutique des réponses immunes trouve son intérêt dans :

- A- les déficits immunitaires.
- B- Les maladies infectieuses.
- C- Les maladies allergiques.
- D- Les maladies auto immunes.
- E- L'immunité anticancéreuse.

Source: Q26 P2018

20. les thérapeutiques immunologiques proposées dans les maladies auto immunes peuvent cibler :

- A- La maturation des cellules dendritique.
- B- La prolifération des cellules T.
- C- La costimulation CD28-CD80/86.
- D- La différenciation des lymphocytes TCD8 +.
- E- Les cytokines de l'inflammation comme l'IL6 et le TNFα.

Source: Q27 P2018

On peut également trouver les informations de cette question dans le cours < Autoimmunité >

21. les inhibiteurs des checkpoints immunitaires ciblent :

- A- Le CD40.
- B- Le CD40L.
- C- Le CTLA4.
- D- Le PD1.
- E- Le PDL1.

Source: Q28 P2018

22. Les immunosuppresseurs ciblent :

- A- L'un des 4 signaux d'activation des LT.
- B- La calcineurine dans le cas la cyclosporine et du tacrolimus.
- C- La transcription du gène de l'IL2 dans le cas d'Azathioprine.
- D- La synthèse de novo des purines dans le cas des stéroïdes.
- E- La signalisation de l'IL2R dans le cas de sirolimus.

Source: Q29 P2018

23. Parmi les domaines suivants, ou est ce que vous pouvez procéder au renforcement du système immunitaire

- A- Maladies autoimmunes.
- B- Maladies allergiques.
- C- Déficits Immunitaires.
- D- Immunité des cancers.
- E- Immunité anti-infectieuse.

Source: Q12 EMD3 P2016

24. La vaccination anti-infectieuse :

- A- Est une immunothérapie active.
- B- Nécessite une faible immunogénicité pour stimuler la mémoire immunologique.
- C- Nécessite une bonne antigénicité.
- D- Des stimulateurs de TLR peuvent être utilisés comme adjuvants.
- E- Contient des adjuvants anti-inflammatoires.

Source: Q13 EMD3 P2016

25. L'Immuno-thérapie des maladies allergiques médiées par les IgE :

- A- Se fait grâce aux extraits d'allergènes et non pas par les protéines recombinantes de l'allergène.
- B- Se réalise par des doses croissantes de l'allergène en sublingual ou en sous-cutané.
- C- Vise à dévier l'immunité adaptative pour produire des IgG4 spécifiques à l'allergène.
- D- Stimule la production des IgG3 hautement cytotoxiques spécifiques de l'allergène.
- E- Provoque la réduction de la production des IgE spécifiques de l'allergène.

Source: Q14 EMD3 P2016

26. Les substances utilisées en immunointervention comprennent :

- A- Antigènes vaccinaux.
- B- Anticorps.
- C- Adjuvants et immunostimulants.
- D- Les Immunosuppresseurs.
- E- Les extraits de lignées tumorales.

Source: Q14 EMD2 P2012

27. La vaccination antipoliomorale :

- A- Utilise des vaccins recombinants.
- B- Utilise des vecteurs.
- C- Utilise des vaccins à ADN.
- D- Induit une réponse et une mémoire immunologique.
- E- à un but préventif et non curatif.

Source: Q15 EMD2 P2012

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐
Q3	☐	☐	☐	☐	☐
Q4	☐	☐	☐	☐	☐
Q5	☐	☐	☐	☐	☐
Q6	☐	☐	☐	☐	☐
Q7	☐	☐	☐	☐	☐
Q8	☐	☐	☐	☐	☐
Q9	☐	☐	☐	☐	☐
Q10	☐	☐	☐	☐	☐
Q11	☐	☐	☐	☐	☐
Q12	☐	☐	☐	☐	☐
Q13	☐	☐	☐	☐	☐
Q14					

	A	B	C	D	E
Q15					
Q16					
Q17	☐	☐	☐	☐	☐
Q18	☐	☐	☐	☐	☐
Q19	☐	☐	☐	☐	☐
Q20	☐	☐	☐	☐	☐
Q21	☐	☐	☐	☐	☐
Q22	☐	☐	☐	☐	☐
Q23	☐	☐	☐	☐	☐
Q24	☐	☐	☐	☐	☐
Q25	☐	☐	☐	☐	☐
Q26	☐	☐	☐	☐	☐
Q27	☐	☐	☐	☐	☐

14. Techniques d'Immunoprécipitation

1. A propos de la technique de Mancini :

A- C'est la technique utilisée pour le diagnostic des maladies des chaînes lourdes.

B- C'est une technique d'immunoprécipitation quantitative par mesure du diamètre du disque de précipitation.

C- Les étalons contiennent la même substance a dosé avec des concentrations connues.

D- L'interaction entre l'antigène et l'anticorps permet la formation d'un arc de précipitation.

E- Elle est appelé aussi la technique d'immunodiffusion radiale simple.

Source: Q23 P2021

2. A propos de l'immunosélection :

A- L'antisérum anti chaîne lourde alpha est incorporé dans le gel.

B- Les antisérums anti kappa et anti lambda sont déposés dans la rigole.

C- Seuls les chaînes lourdes libres pourront diffuser pour former l'arc de précipitation.

D- C'est une technique d'immunotypage des composants monoclonaux.

E- Les antisérums anti kappa et anti lambda empêchent la migration des immunoglobulines entières au cours de l'électrophorèse.

Source: Q24 P2021

3. L'immunosélection :

A- Est une méthode d'immunoprécipitation en milieu liquide.

B- Permet le diagnostic de la maladie de Khaler.

C- Détecte la présence de chaînes lourdes libres.

D- Est une technique qualitative.

E- Est réalisée en une seule étape.

Source: Q20 P2021 RATRAPAGE

4. L'électrophorèse des protéines sériques :

A- Est une technique qualitative.

B- Repose sur la séparation des protéines sous l'effet d'un champ électrique.

C- Fait appel à une courbe d'étalonnage.

D- Résulte en la formation de 6 zones électrophorétiques.

E- Permet l'identification et le typage d'une immunoglobuline monoclonale.

Source: Q26 P2020

5. Lesquelles, parmi les techniques d'immunoprécipitation suivantes, sont quantitatives?

A- Technique de Mancini.

B- Technique d'Ouchterlony.

C- Technique d'immuno-néphélométrie.

D- Ring test.

E- Technique d'Oudin.

Source: Q27 P2020

6. Citer 03 techniques immunologiques quantitatives sans marqueur :

Source: Q12 P2020 RATRAPAGE

(QROC).

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐
Q3	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q4	☐	☐	☐	☐	☐
Q5	☐	☐	☐	☐	☐
Q6	☐	☐	☐	☐	☐

15. Réaction d'Agglutination et d'Hemagglutination

1. Parmi les réactions d'agglutination active :

A- Le test de Coombs indirect.

B- Le groupage sanguin par la technique de Beth-Vincent.

C- Le sérodiagnostic de Widal.

D- La recherche du facteur rhumatoïde par la réaction de Latex.

E- La recherche du facteur rhumatoïde par la technique de Waaler-Rose.

Source: Q25 P2021

2. Laquelle des réactions suivantes est une réaction d'agglutination :

A- Mancini.

B- Immunofixation.

C- La néphélométrie.

D- Le test de Coombs indirect.

E- L'électrophorèse des protéines sériques sur gel d'agarose.

Source: Q19 P2021 RATRAPAGE

3. À propos des réactions d'hémagglutination :

A- Sont des méthodes quantitatives.

B- L'antigène est exprimé à la surface d'une particule de latex.

C- Sont favorisées par l'agitation in vitro.

D- Le test de Coombs direct en est un exemple.

E- Le test de Coombs indirect en est un exemple.

Source: Q28 P2020

4. Les paramètres suivant favorisant les réactions d'agglutination :

A- La manipulation à une température de 37 C.

B- L'agitation.

C- Le pH très acide.

D- La présence de certaines protéines augmentant le potentiel Zêta.

E- Les anticorps d'isotype IgM.

Source: Q19 P2019

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q3	☐	☐	☐	☐	☐
Q4	☐	☐	☐	☐	☐

16. Techniques Immunologiques utilisant des anticorps marqués

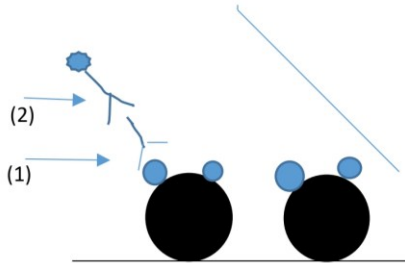
1. Les techniques immunologiques d'immunofluorescence :

- A- Nécessitent un densitomètre pour la mesure du signal.
- B- Nécessitent l'utilisation d'une source de rayons ultraviolets.
- C- Nécessitent la conjugaison de l'anticorps avec un fluorochrome.
- D- Nécessitent la conjugaison de l'anticorps avec un radio-isotope.
- E- Peuvent être de type direct et indirect.

Source: Q29 P2020

2. Dans le montage technique ci-après :

- A- Le (1) correspond à l'anticorps primaire.
- B- Le (1) correspond à l'anticorps secondaire.
- C- Le (1) correspond à l'anticorps conjugué.
- D- Le (2) correspond à l'anticorps secondaire.
- E- Le (2) correspond à l'anticorps conjugué.



Source: Q30 P2020

3. Les techniques radio immunologiques par compétition

- A- Utilisent un marqueur radioactif.
- B- Sont basées sur la compétition entre anticorps et antigènes.
- C- Sont basées sur la compétition entre des anticorps marqués et non marqués.
- D- Sont basées sur la compétition entre des antigènes marqués et non marqués.
- E- [... La proposition n'est pas affichée dans le sujet original].

Source: Q20 P2019

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q3	☐	☐	☐	☐	☐

17. Autres

1. Sont considérés comme éléments de mauvais pronostic d'une tumeur : (1a RF)

- A- Infiltration de la masse tumorale par des lymphocytes T cytotoxiques.
- B- Production massive de prostaglandine E2.
- C- Augmentation de la synthèse d'interleukine 10 (IL-10).
- D- Diminution de l'expression des molécules HLA like (MIC) par les cellules tumorales.
- E- Dissémination des cellules tumorales aux tissus avoisinants.

Source: Q17 EMD2 P2014

2. L'activité anti-tumorale des cellules NK se traduit par : (1a RF)

- A- Libération des granules intra-cytoplasmiques.
- B- Une activation de la cytotoxicité naturelle.
- C- L'engagement de FC gamma R CD16.
- D- Libération d'interleukine 10.
- E- L'engagement des couples FAS-FASL, TNF-TNFR, TRAIL-TRAILR.

Source: Q18 EMD2 P2014

3. Parmi les mécanismes d'échappement au système immunitaire utilisés par les cellules tumorales: (1a RF)

- A- Recrutement des lymphocytes T Reg.
- B- Production de TOF beta.
- C- Réduction d'expression des molécules de MICA.
- D- Expression des molécules de CD95L.
- E- Altération de TH1.

Source: Q19 EMD1 P2010

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
Q3	☐	☐	☐	☐	☐

RÉPONSES

1. Immunopathologie

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☒

	A	B	C	D	E
Q2	☐	☒	☐	☐	☒

2. Immunité Antibactérienne

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☒
Q2	☒	☒	☒	☐	☒

	A	B	C	D	E
Q3	☐	☐	☒	☒	☒
Q4	☒	☐	☒	☐	☒

3. Immunité Antiparasitaire

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☒	☐	☐	☒
Q2	☒	☒	☐	☐	☒
Q3	☐	☐	☒	☒	☒

	A	B	C	D	E
Q4	☒	☒	☐	☒	☐
Q5	☒	☐	☐	☒	☐

4. Immunité Antivirale

	A	B	C	D	E
Q1	☒	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☒	☐
Q3	☒	☒	☐	☒	☐
Q4	☒	☒	☐	☐	☒
Q5	☒	☐	☐	☐	☐
Q6	☒	☐	☒	☐	☐
Q7	☒	☒	☒	☐	☐
Q8	☐	☒	☐	☒	☒

	A	B	C	D	E
Q9	☒	☐	☐	☒	☒
Q10					
Q11	☒	☒	☒	☐	☐
Q12	☒	☒	☒	☐	☐
Q13	☒	☒	☐	☒	☐
Q14	☒	☒	☒	☐	☐
Q15	☒	☒	☒	☒	☒

5. Hypersensibilité type I

	A	B	C	D	E
Q1	☒	☐	☒	☒	☐
Q2	☒	☐	☐	☒	☒
Q3	☐	☒	☐	☐	☐
Q4	☐	☐	☐	☒	☐
Q5	☒	☐	☐	☐	☒
Q6	☐	☐	☒	☒	☐
Q7	☐	☒	☒	☐	☐
Q8	☐	☐	☒	☒	☒
Q9	☐	☐	☒	☐	☐
Q10	☒	☒	☐	☒	☐
Q11	☒	☐	☐	☐	☐
Q12	☐	☐	☒	☐	☐
Q13	☒	☒	☒	☒	☒
Q14	☒	☒	☒	☒	☒
Q15	☒	☒	☒	☒	☒
Q16	☒	☒	☒	☒	☒

	A	B	C	D	E
Q17	☒	☒	☒	☒	☒
Q18	☒	☒	☒	☒	☒
Q19	☒	☒	☒	☒	☒
Q20	☒	☒	☒	☒	☒
Q21	☒	☒	☒	☒	☒
Q22	☒	☒	☒	☒	☒
Q23	☒	☒	☒	☒	☒
Q24	☒	☒	☒	☒	☒
Q25	☒	☒	☒	☒	☒
Q26	☒	☒	☒	☒	☒
Q27	☒	☒	☒	☒	☒
Q28	☒	☒	☒	☒	☒
Q29	☒	☒	☒	☒	☒
Q30	☒	☒	☒	☒	☒
Q31	☒	☒	☒	☒	☒

6. Hypersensibilité type II

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☒	☐	☐
Q2	☐	☐	☒	☒	☒
Q3	☒	☐	☒	☐	☒
Q4	☒	☒	☐	☐	☐
Q5					
Q6	☒	☐	☐	☒	☒
Q7	☐	☒	☐	☒	☐

	A	B	C	D	E
Q8	☒	☒	☐	☒	☒
Q9	☒	☐	☐	☒	☐
Q10	☐	☒	☒	☒	☐
Q11	☒	☒	☒	☒	☒
Q12	☒	☒	☒	☒	☒
Q13	☒	☒	☒	☒	☒
Q14	☒	☒	☒	☒	☒

7. Hypersensibilité type III

	A	B	C	D	E
Q1	☒	☐	☐	☒	☐
Q2	☐	☐	☒	☒	☐
Q3	☒	☐	☐	☒	☐
Q4					
Q5	☐	☒	☐	☒	☒
Q6	☐	☒	☒	☒	☐
Q7	☐	☒	☐	☒	☒

	A	B	C	D	E
Q8	☐	☐	☒	☒	☐
Q9	☒	☒	☒	☒	☒
Q10	☒	☒	☒	☒	☒
Q11	☒	☒	☒	☒	☒
Q12	☒	☒	☒	☒	☒
Q13	☒	☒	☒	☒	☒
Q14	☐	☐	☐	☐	☒

8. Hypersensibilité type IV

	A	B	C	D	E
Q1	☒	☐	☐	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☐	☒
Q3	☐	☒	☐	☒	☒
Q4	☒	☒	☒	☒	☒
Q5	☐	☐	☒	☒	☒
Q6	☒	☐	☐	☒	☒
Q7	☐	☐	☐	☒	☐
Q8	☒	☐	☐	☒	☒

	A	B	C	D	E
Q9	☒	☒	☐	☒	☐
Q10	☒	☒	☐	☒	☐
Q11	☐	☒	☐	☒	☐
Q12	☐	☐	☐	☒	☐
Q13	☒	☒	☒	☒	☒
Q14	☒	☒	☒	☒	☒
Q15	☒	☒	☒	☒	☒

9. Autoimmunité

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☒	☐
Q2	☐	☐	☒	☒	☐
Q3	☐	☐	☒	☐	☐
Q4	☒	☐	☒	☐	☒
Q5	☒	☐	☐	☒	☒
Q6	☐	☒	☐	☒	☐
Q7	☐	☐	☒	☐	☐
Q8	☐	☐	☐	☐	☒
Q9					
Q10	☐	☒	☒	☐	☒

	A	B	C	D	E
Q11	☒	☒	☒	☐	☐
Q12	☒	☒	☒	☐	☐
Q13	☐	☒	☒	☐	☒
Q14	☐	☐	☒	☐	☐
Q15	☒	☒	☒	☒	☒
Q16	☒	☒	☒	☒	☒
Q17	☒	☐	☐	☐	☐
Q18	☐	☐	☐	☐	☒
Q19	☐	☐	☐	☒	☐

10. Deficits Immunitaires

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☒	☒
Q2	☐	☐	☐	☒	☐
Q3	☒	☐	☐	☐	☒
Q4	☒	☐	☒	☒	☐
Q5	☐	☐	☒	☒	☒
Q6	☐	☐	☒	☐	☒
Q7	☐	☒	☐	☐	☐
Q8	☒	☐	☒	☐	☒
Q9	☒	☒	☒	☐	☐
Q10	☒	☒	☒	☐	☐
Q11	☐	☒	☒	☐	☒
Q12					
Q13					
Q14	☐	☒	☐	☐	☐
Q15	☐	☐	☒	☒	☒
Q16	☒	☒	☐	☐	☒
Q17	☐	☐	☒	☒	☐
Q18	☒	☒	☒	☐	☒
Q19	☐	☐	☒	☐	☐
Q20	☒	☒	☒	☒	☒

	A	B	C	D	E
Q21	☒	☒	☒	☒	☒
Q22	☒	☒	☒	☒	☒
Q23	☒	☒	☒	☒	☒
Q24	☒	☒	☒	☒	☒
Q25	☒	☒	☒	☒	☒
Q26	☒	☒	☒	☒	☒
Q27	☒	☒	☒	☒	☒
Q28	☒	☒	☒	☒	☒
Q29	☒	☒	☒	☒	☒
Q30	☒	☒	☒	☒	☒
Q31	☒	☒	☒	☒	☒
Q32	☒	☒	☒	☒	☒
Q33	☒	☒	☒	☒	☒
Q34	☐	☐	☒	☐	☐
Q35	☐	☐	☐	☐	☒
Q36	☐	☒	☐	☐	☐
Q37	☐	☐	☐	☒	☐
Q38	☐	☐	☒	☐	☐
Q39	☐	☒	☐	☐	☐

11. Syndromes Lymphoprolifératifs

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☐	☐	☐	☒
Q2	☐	☐	☐	☒	☐
Q3	☐	☐	☒	☒	☐
Q4	☒	☒	☐	☐	☒
Q5	☒	☐	☒	☒	☒
Q6	☒	☐	☒	☒	☐
Q7	☐	☒	☐	☒	☒
Q8	☒	☐	☒	☒	☒
Q9					
Q10	☒	☐	☒	☒	☐
Q11	☐	☐	☒	☒	☐

	A	B	C	D	E
Q12	☒	☒	☒	☒	☒
Q13	☒	☒	☒	☒	☒
Q14	☒	☒	☒	☒	☒
Q15	☒	☒	☒	☒	☒
Q16	☒	☒	☒	☒	☒
Q17	☒	☒	☒	☒	☒
Q18	☐	☐	☐	☒	☐
Q19	☐	☐	☒	☐	☐
Q20	☐	☐	☐	☒	☐
Q21	☐	☐	☐	☐	☒

12. Transplantation (Grefe)

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☒	☐	☒	☐
Q2	☐	☒	☐	☐	☐
Q3	☐	☐	☒	☐	☐
Q4	☒	☐	☐	☒	☐
Q5	☐	☒	☐	☐	☐
Q6	☒	☐	☐	☐	☒
Q7	☒	☐	☒	☐	☒

	A	B	C	D	E
Q8					
Q9	☒	☐	☐	☒	☒
Q10	☒	☒	☒	☒	☒
Q11	☒	☒	☒	☒	☒
Q12	☒	☒	☒	☒	☒
Q13	☒	☒	☒	☒	☒

13. Immunothérapie & Immunosuppression

	A	B	C	D	E
Q1	☒	☐	☒	☐	☐
Q2	☒	☒	☐	☐	☒
Q3	☒	☐	☐	☒	☒
Q4	☐	☒	☒	☐	☒
Q5	☐	☒	☐	☒	☐
Q6	☐	☐	☐	☒	☐
Q7	☒	☒	☐	☐	☒
Q8	☒	☐	☐	☐	☒
Q9	☐	☒	☒	☐	☐
Q10	☐	☒	☒	☐	☐
Q11	☐	☒	☒	☐	☐
Q12	☐	☒	☐	☒	☐
Q13	☐	☐	☒	☐	☒
Q14					

	A	B	C	D	E
Q15					
Q16					
Q17	☐	☐	☒	☐	☒
Q18	☐	☒	☐	☐	☒
Q19	☐	☐	☒	☒	☐
Q20	☐	☒	☒	☐	☒
Q21	☐	☐	☒	☒	☒
Q22	☒	☒	☐	☐	☒
Q23	☒	☒	☒	☒	☒
Q24	☒	☒	☒	☒	☒
Q25	☒	☒	☒	☒	☒
Q26	☐	☐	☐	☐	☒
Q27	☐	☐	☐	☐	☒

14. Techniques d'Immunoprecipitation

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☒	☒	☐	☒
Q2	☐	☐	☒	☐	☒
Q3	☐	☐	☒	☒	☐

	A	B	C	D	E
Q4	☒	☒	☐	☒	☐
Q5	☒	☐	☒	☐	☒
Q6					

15. Réaction d'Agglutination et d'Hemagglutination

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☒	☒	☐	☐
Q2	☐	☐	☐	☒	☐

	A	B	C	D	E
Q3	☐	☐	☒	☒	☒
Q4	☒	☒	☐	☐	☒

16. Techniques Immunologiques utilisant des anticorps marqués

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☒	☒	☐	☒
Q2	☒	☐	☐	☒	☒

	A	B	C	D	E
Q3	☒	☐	☐	☒	☐

17. Autres

	A	B	C	D	E
Q1	☒	☒	☒	☒	☒
Q2	☒	☒	☒	☒	☒

	A	B	C	D	E
Q3	☒	☒	☒	☒	☒

RÉPONSES des QROC

[C4-Q10] Citer 04 mécanismes d'échappement immunitaire des virus :

- Variation antigénique (drift, shift).
- Destruction de cellules immunitaires (VIH).
- Inhibition du système du complément.
- Induction d'un état d'épuisement lymphocytaire.

[C6-Q5] Citer 03 mécanismes immunopathologiques de l'hypersensibilité de type II :

- Opsonisation et phagocytose.
- Cytotoxicité cellulaire dépendante de l'anticorps (ADCC).
- Cytotoxicité dépendante du complément (CDC).

[C7-Q4] Citer 03 pathologies à hypersensibilité de type III :

- La maladie sérique.
- La maladie des poumons de fermier.
- Lupus érythémateux systémique.

[C9-Q9] Citer 04 mécanismes étiologiques de l'auto-immunité :

- Mimétisme moléculaire / réactions croisées avec des antigènes infectieux.
- Défaut de la sélection négative des thymocytes (rupture de la tolérance centrale).
- Défaut fonctionnel des LT régulateurs (rupture de la tolérance périphérique).
- Libération d'antigènes séquestrés (traumatisme de l'œil..)

[C10-Q12] Citer 03 déficits immunitaires primitifs à transmission liée au sexe:

- Agammaglobulinémie de Bruton.
- Le syndrome de Wiskott-Aldrich.
- Le déficit en chaîne gamma commune (SCID lié à l'X).

[C10-Q13] Citer 04 gènes dont la mutation causerait un déficit immunitaire combiné sévère :

- RAG1/2 (enzymes responsables des réarrangements du TCR et BCR)
- IL7RA (chaîne α du récepteur de l'IL7).
- CD3 δ, ϵ, ζ .
- ADA (adenosine deaminase)

[C11-Q9] Citer 04 signes biologiques d'une macroglobulinémie de Waldenström :

- Immunoglobuline monoclonale IgM 19S.
- Cryoglobulinémies type I/II.
- Thrombopénie.
- Anémie.

[C12-Q8] Citer 04 événements immunisants causant l'apparition d'anticorps anti-HLA:

- Greffe antérieure/rejet de greffe.
- Transfusions sanguines.
- Grossesses.
- Infections/vaccinations.

[C13-14] Citer 04 immunosuppresseurs ciblant le LT :

- Anticorps monoclonaux anti-CD25.
- Glucocorticoïdes.
- Ciclosporine A.
- Tacrolimus (FK506).

[C13-Q15] Citer 02 avantages des vaccins vivants atténués :

- Produisent des réponses immunitaires adaptatives cellulaires en plus des réponses humorales.
- Ne nécessitent pas de rappels.

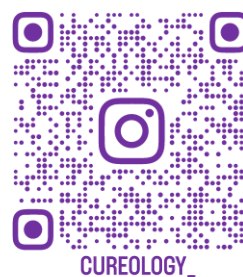
[C13-Q16] Citer 02 inconvénients des vaccins vivants atténués:

- Contreindiqués chez le sujet immunodéprimé et la femme enceinte.
- Sensibles à la chaîne de froid (difficultés de conservation).

[C14-Q6] Citer 03 techniques immunologiques quantitatives sans marqueur :

- Immunodiffusion radiale (technique de Mancini).
- Turbidimétrie.
- Néphélométrie.

Merci pour votre confiance en la série



Restons en contact !

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ
عَدَدُ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِينَةُ عَرْشِهِ وَمَدَادُ كَلِمَاتِهِ
سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ